SUIVI-ÉVALUATION · GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS

CONSORTIUM SANRU – ICHESS – FONLIV – FDSS
Chef de file : SANRU

PLAN DE SUIVI-ÉVALUATION 2027 – 2028

Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé — Volet Nutrition à Assise Communautaire (PMNS-NAC), province du Kwilu, RDC

PROJET DE RÉFÉRENCE

PMNS-NAC Kwilu
10 zones de santé · 250 aires de santé · 3 188 villages

Document source : Tech-4 — Description de l'approche, de la méthodologie et du programme de travail
Demande de Propositions N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS

Période de mise en œuvre : 1er janvier 2027 – 31 décembre 2028

Version 1.0 — document de travail soumis à validation

Élaboré exclusivement à partir du document Tech-4 du consortium. Aucune donnée, cible ou valeur de référence n'a été ajoutée : les informations absentes de la source sont signalées « À préciser ».

Sommaire

Résumé exécutif 4

1 Présentation générale du projet 10

1.1 Identification du projet 10
1.2 Contexte et justification 10
1.3 Objectif général 11
1.4 Objectifs spécifiques 13
1.5 Principales composantes et interventions 13
1.6 Zones d'intervention et population cible 13

2 Théorie du changement et logique d'intervention 13

2.1 Le modèle Environnement – Demande – Offre (EDO) retenu par le consortium 14
2.2 Chaîne des résultats 15
2.3 Éléments de causalité à valider 15

3 Objectifs du système de suivi-évaluation 15

3.1 Objectif général du dispositif 15
3.2 Objectifs spécifiques 15
3.3 Besoins en information par niveau de décision 16
3.4 Utilisation des données pour la prise de décision 16

4 Approche méthodologique 16

4.1 Architecture générale du dispositif 17
4.2 Suivi de la mise en œuvre 17
4.3 Suivi des résultats 18
4.4 Suivi des indicateurs 18
4.5 Évaluations périodiques 29
4.6 Collecte quantitative et qualitative 29
4.7 Triangulation des informations 29
4.8 Assurance qualité des données 30
4.9 Documentation et capitalisation 30

5 Dispositif de suivi des indicateurs 31

5.1 Registre des indicateurs — vue matricielle 31
5.2 Indicateurs par objectif et par niveau de résultat 31
5.3 Procédure de fixation des valeurs de référence et des cibles 32
5.4 Désagrégations retenues 33
5.5 Indicateurs non retenus et justification 33
5.6 Cohérence entre les livrables 33

6 Organisation institutionnelle du suivi-évaluation 34

6.1 Acteurs et responsabilités documentés 35
6.2 Matrice RACI proposée 35
6.3 Dispositif institutionnel 35

7 Outils de collecte et de gestion des données 37

7.1 Architecture des données 38
7.2 Protection des données et éthique 39
7.3 Garanties de confidentialité et responsabilités associées 39

8 Assurance qualité des données 39

8.1 Mécanismes de contrôle et de validation à trois niveaux 40

8.2 Plan d'audit de la qualité des données 42

9 Plan de reporting 43

9.1 Normes de production des rapports 43

10 Planification des activités de suivi-évaluation 2027–2028 43

10.1 Exercice 2027 44

10.2 Exercice 2028 44

10.3 Justification de la programmation 44

11 Gestion des risques du dispositif de suivi-évaluation 45

11.1 Dispositif de suivi des risques 45

11.2 Instances de revue des risques et calendrier de traitement 45

11.3 Conséquences opérationnelles des risques majeurs 46

12 Utilisation des résultats 46

12.1 Boucle d'apprentissage 46

12.2 Redevabilité envers les communautés 47

13 Annexes 48

13.1 Annexe A — Référentiel des activités de suivi-évaluation issues de Tech-4

13.2 Annexe B — Modèle de fiche de suivi d'indicateur

13.3 Annexe C — Canevas du rapport d'avancement périodique

13.4 Annexe D — Matrice de traçabilité documentaire

13.5 Annexe E — Informations manquantes à obtenir

13.6 Annexe F — Sigles et abréviations

13.7 Annexe G — Documents de référence

SECTION

Résumé exécutif

Le présent plan organise, pour la période 2027–2028, le dispositif de suivi-évaluation du Projet Multisectoriel de Nutrition et de Santé – volet Nutrition à Assise Communautaire (PMNS-NAC) dans la province du Kwilu, tel que décrit dans le formulaire TECH-4 de la Demande de Propositions N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS.

Le document Tech-4 constitue l'unique source de référence. Aucun objectif, résultat, indicateur, montant, volume ou mécanisme institutionnel n'a été ajouté. Lorsque l'information nécessaire au suivi-évaluation n'y figure pas — en particulier les **valeurs de référence** et les **cibles annuelles** — la mention « **À préciser** » est utilisée, et la méthode permettant de la produire est proposée et signalée comme **recommandation à valider**.

Contexte du projet

La province du Kwilu présente une situation nutritionnelle critique, documentée dans Tech-4 : 47 % d'enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance, 34,8 % d'insuffisance pondérale, la prévalence de l'insécurité alimentaire sévère atteint 49,9 % (contre 43,7 % au niveau national) et seuls 32,7 % des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois. La couverture des interventions de nutrition dans les formations sanitaires des dix zones de santé ciblées demeure faible : CPSr 47,1 %, ANJE 50 %, PCIMA et NAC 0 % (rapport annuel PRONANUT Kwilu 2020, cité par Tech-4). Aucune zone de santé de la province n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019.

Objectifs et résultats attendus

L'objectif global retenu par Tech-4 est d'**accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté**. Il se décline en quatre objectifs spécifiques — mise en œuvre des activités dans les sites communautaires (OS1), prévention et prise en charge des violences basées sur le genre (OS2), renforcement des structures de participation communautaire (OS3) et appui au système de santé dans les FOSA (OS4) — complétés par un résultat intermédiaire consacré au suivi-évaluation, à la redevabilité et à l'apprentissage (RI 4.5).

Approche de suivi-évaluation retenue

Le dispositif articule quatre niveaux : (i) le **suivi de la mise en œuvre** à partir des rapports d'activité mensuels et du programme de travail de Tech-4 ; (ii) le **suivi des résultats** au moyen d'indicateurs d'extrants et d'effets ; (iii) le **suivi de la qualité** par les supervisions formatives, les audits de données et le Monitorage amélioré pour l'action (MAA) ; (iv) les **évaluations** — de base, à mi-parcours et finale — prévues par Tech-4. La triangulation s'appuie sur trois familles de sources : données de routine (DHIS2), registres communautaires électroniques et enquêtes périodiques.

41	14	2	10
indicateurs documentés	résultats intermédiaires	années couvertes	zones de santé suivies

Principaux outils de mesure

Les outils sont ceux que Tech-4 mentionne explicitement : registres de FOSA (registres UNTA/UNTI, fiches de suivi individuel, fiches CPS, fiches de référence et contre-référence), registre communautaire électronique déployé auprès des RECO et des présidents de CAC, plateforme DHIS2, canevas de supervision, bulletins de performance communautaire (BCP), enquêtes SMART et enquêtes de satisfaction semestrielles. Les outils complémentaires proposés par le présent plan sont identifiés comme tels.

Avertissement méthodologique

Tech-4 ne contient **aucune valeur de référence propre au projet** pour les 14 résultats intermédiaires, et **aucune cible annuelle**. Les seules cibles chiffrées disponibles sont des volumes de livrables (par exemple 3 188 CAC, 8 314 RECO, 423 FOSA, 30 FARN) et quelques objectifs de performance ponctuels (au moins 80 % des enfants MAS référés pris en charge ; 80 % des femmes réalisant la CPN à la 16e semaine). Ces cibles sont reproduites telles quelles et positionnées globalement ; leur ventilation entre 2027 et 2028 n'est **pas** documentée et doit être arbitrée lors de l'atelier de validation des cibles (recommandation).

Période couverte

Le plan couvre une période de deux ans : **année 1 (1er janvier – 31 décembre 2027)** et **année 2 (1er janvier – 31 décembre 2028)**. Tech-4 décrit une mise en œuvre de 18 mois et fixe l'échéance des objectifs au 31 décembre 2023 ; l'exercice 2027–2028 constitue donc une **reprogrammation temporelle** des mêmes objectifs, résultats et activités, sans modification de leur libellé ni de leur portée. Ce décalage est signalé comme point de vigilance en section 11 (risque R12) et en annexe E.

Nature et portée du dispositif

Le dispositif retenu est un **suivi-évaluation de gestion axée sur les résultats**. Il ne se substitue pas au système national d'information sanitaire : il l'utilise comme source principale et ajoute ce que le système national ne couvre pas — le registre électronique communautaire, la mesure de la fonctionnalité des structures de participation, le suivi individualisé des bénéficiaires et l'évaluation de la qualité des services. Cette articulation est celle que Tech-4 décrit au §RI 4.5.

Trois principes gouvernent sa construction. **Premièrement, la fidélité documentaire** : tout objectif, résultat, indicateur, volume et mécanisme institutionnel provient de Tech-4 ; les apports du présent plan sont identifiés comme tels. **Deuxièmement, la séparation stricte** entre ce qui est documenté et ce qui est proposé — les recommandations sont signalées dans des encadrés dédiés et rappelées dans les tableaux. **Troisièmement, la cohérence entre livrables** : le registre des indicateurs de la section 5 est la source unique du cadre de performance (livrable 03) et des fiches techniques (livrable 04).

Structure du document

Structure du plan de suivi-évaluation

Section	Objet	Livrable lié
1 à 4	Présentation du projet, théorie du changement, objectifs du dispositif et approche méthodologique	—
5	Registre des indicateurs : 14 colonnes, définitions, formules, références et cibles	Livrables 03 et 04
6 à 9	Organisation institutionnelle, outils de collecte, assurance qualité, plan de reporting	—
10 et 11	Planification 2027–2028 et gestion des risques	—
12 et 13	Utilisation des résultats et annexes (référentiel, canevas, traçabilité, sigles)	Livrable 05

Le rapport de contrôle qualité (livrable 05) documente la traçabilité, les informations manquantes et les contrôles effectués sur l'ensemble des livrables.

SECTION 1

Présentation générale du projet

1.1 Identification du projet

Tableau 1 — Fiche d'identification du projet

Élément	Contenu	Source
Intitulé de la mission	Services de consultants (ONG) chargés de la mise en œuvre des services de nutrition à assise communautaire (NAC) dans la province du Kwilu	Tech-4, page de garde
Document de référence	Demande de Propositions (DP) N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS — Formulaire TECH-4 (description de l'approche, de la méthodologie et du programme de travail)	Tech-4, page de garde
Groupement	Consortium SANRU – ICHESS – FONLIV – FDSS, chef de file : SANRU	Tech-4, page de garde
Bailleur / maître d'ouvrage	UG-PDSS (Unité de Gestion du Programme de Développement du Système de Santé) ; évaluations mensuelles de vérification des performances et rapports transmis à l'UG-PDSS	Tech-4, RI 4.4
Tutelle technique	Ministère de la Santé publique, hygiène et prévention (MSPHP) ; DPS Kwilu ; PRONANUT ; PNSR	Tech-4, §RI 4.4
Province	Kwilu (RDC), 5 territoires (Bagata, Bulungu, Gungu, Idiofa, Masimanimba) et 2 villes (Kikwit, Bandundu)	Tech-4, §1.1
Zones de santé ciblées	10 ZS : Djuma, Gungu, Kikwit Nord, Kimputu, Kingandu, Moanza, Mosango, Pay Kongila, Sia, Yasa Bonga	Tech-4, Tableau « Répartition et fonctionnalité des structures communautaires »
Aires de santé	250 aires de santé	Tech-4, §Objectif 1
Villages	3 188 villages (dont 2 250 disposant d'une CAC en 2021, soit 71 %)	Tech-4, §OS3
Formations sanitaires	423 FOSA (413 centres de santé abritant les UNTA et 10 HGP abritant les UNTI)	Tech-4, §RI 4.1
Population cible	Femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants de 0 à 59 mois, adolescentes ; groupes d'influence (grands-mères, pères, chefs traditionnels et religieux, RECO, prestataires)	Tech-4, §1.3
Durée indiquée dans Tech-4	18 mois ; objectifs assignés « d'ici 31 décembre 2023 »	Tech-4, §1.3 et §RI 4.2
Période du présent plan	1er janvier 2027 – 31 décembre 2028 (deux exercices)	Cadrage de la mission

Toutes les données de ce tableau sont issues de Tech-4. La durée de 18 mois et l'échéance de 2023 y sont explicitement mentionnées ; le présent plan les prolonge sur 2027–2028 (voir section 12).

1.2 Contexte et justification

Tech-4 documente une situation nutritionnelle préoccupante à l'échelle nationale et provinciale. En RDC, 42 % des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance (MICS-Palu 2017-2018) ; cette proportion atteint 52 % dans les ménages les plus pauvres contre 18 % dans les plus riches. Dans la province du Kwilu, les indicateurs sont plus dégradés encore que la moyenne nationale.

Tableau 2 — Situation de référence provinciale documentée dans Tech-4

Indicateur de situation	Kwilu	National	Source citée par Tech-4
Retard de croissance, enfants < 5 ans	47 %	42 %	MICS-Palu 2017-2018 / MICS 6
Insuffisance pondérale, enfants < 5 ans	34,8 %	Non renseigné dans le document source	Tech-4 §1.1

Indicateur de situation	Kwilu	National	Source citée par Tech-4
Insécurité alimentaire sévère	49,9 %	43,7 %	IPC 2021-2022
Insécurité alimentaire modérée à sévère	67,5 %	65,5 %	IPC 2021-2022
Initiation précoce à l'allaitement	29,2 %	46,9 %	MICS
Allaitement maternel exclusif à 6 mois	32,7 %	53,5 %	MICS
Allaitement maternel continu jusqu'à 24 mois	78,1 %	Non renseigné dans le document source	MICS
Alimentation de complément adéquate (6-23 mois)	18 %	Non renseigné dans le document source	Tech-4 §1.1
Diversité alimentaire minimale	27,1 %	Non renseigné dans le document source	MICS
Au moins 4 CPN pendant la grossesse	24,3 %	42,9 %	MICS
Ménages avec installation de lavage des mains (eau + savon)	18 %	Non renseigné dans le document source	MICS
Population utilisant une source améliorée d'eau	29 %	Non renseigné dans le document source	MICS
Population vivant avec moins de 1,90 USD/jour	93,2 %	74,7 %	Tech-4 §1.1
Couverture en CAC (villages)	71 % (2 250/3 188)	Non renseigné dans le document source	DPS Kwilu 2021
CAC ayant tenu toutes les réunions mensuelles en 2021	53,6 %	Non renseigné dans le document source	DHIS2 2021
CAC disposant d'un plan d'action communautaire	16 %	30 %	PSNSC 2019-2022

*Ces valeurs constituent le **contexte** du projet ; elles ne sont pas des cibles et ne peuvent pas être utilisées comme valeurs de référence du cadre de performance, Tech-4 ne les rattachant pas explicitement aux indicateurs du projet (voir section 6).*

Tech-4 identifie cinq familles de causes immédiates et sous-jacentes : la mauvaise qualité de l'alimentation (pratiques ANJE inadaptées, régime peu diversifié), l'insécurité alimentaire aiguë, les maladies infantiles et épidémies (paludisme, diarrhée, rougeole, géo-helminthiases, anémie), les mauvaises conditions d'hygiène et d'accès à l'eau, enfin les effets de la situation sécuritaire et des catastrophes naturelles. Le cadre conceptuel retenu est celui de l'UNICEF, adapté au contexte du Kwilu par le consortium.

1.3 Objectif général

Objectif global (Tech-4, cadre logique)

Accroître l'accès et l'utilisation du paquet de services de nutrition de qualité dans les FOSA et dans la communauté.

Indicateur objectivement vérifiable (I.O.V.) associé par Tech-4 : nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition.

Tech-4 précise par ailleurs que l'objectif ultime du projet est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liées à la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes (FEFA) dans les 10 zones de santé de la province du Kwilu, tout en signalant que *« l'impact du projet ne sera pas analysé au cours de cette évaluation car ceci nécessitera une étude plus approfondie »*.

1.4 Objectifs spécifiques

Tableau 3 — Objectifs spécifiques et résultats intermédiaires (libellés conformes à Tech-4)

Code	Objectif spécifique	Résultats intermédiaires associés
OS1	Assurer la mise en œuvre des activités dans les sites communautaires conformément aux objectifs établis et convenus (qualité et couverture) pour améliorer l'accès, l'utilisation et la qualité d'un ensemble de services communautaires de nutrition et de santé	RI 1.1 Accès et utilisation améliorés RI 1.2 Approches innovantes documentées RI 1.3 Qualité des services communautaires améliorée
OS2	Sensibiliser sur les violences basées sur le genre et développer un système de prestation de services pour la prise en charge des victimes de la violence sexuelle et sexiste	RI 2.1 Comités locaux VBG mis en place et actifs RI 2.2 Communautés sensibilisées et engagées RI 2.3 Système de prise en charge des SVS renforcé
OS3	Soutenir les structures de participation communautaire au niveau des communautés et des Zones de Santé afin d'améliorer la gestion et la mise en œuvre des services de nutrition et de santé communautaires	RI 3.1 Organisation et fonctionnement des structures renforcés RI 3.2 Leadership et capacités managériales renforcés RI 3.3 Coordination multisectorielle renforcée
OS4	Appuyer le système de santé dans l'amélioration, l'utilisation et la qualité des services de nutrition dans les FOSA, selon les normes et standards nationaux	RI 4.1 Offre et utilisation des services améliorées RI 4.2 Qualité des services améliorée RI 4.3 Coordination des interventions renforcée RI 4.4 Mise en œuvre assurée RI 4.5 Suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage assurés

Les libellés sont reproduits sans modification de sens. Tech-4 présente le RI 4.5 comme un résultat intermédiaire de l'OS4 ; le présent plan le traite également comme le cinquième domaine programmatique, ce qui explique la codification « OS5 » utilisée dans les fiches d'indicateurs.

1.5 Principales composantes et interventions

Tableau 4 — Composantes, interventions et volumes issus de Tech-4

Composante	Interventions documentées dans Tech-4	Volumes et cibles du document source
Nutrition à assise communautaire (NAC)	Formation et équipement des prestataires communautaires ; VAD ; dépistageMUAC ; distribution de vitamine A et déparasitage ; CPSr en stratégie avancée ; promotion de l'ANJE et des PFE ; démonstrations culinaires ; BCP	3 188 CAC · 8 314 RECO · 190 SSC · 150 émissions radio · 10 spots ANJE
Approches innovantes	Approche « PB Famille » ; Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle (FARN) ; prise en charge communautaire de la MAM avec aliments locaux (modèle IMA/SANRU) ; registre électronique ; AFASAC	30 FARN dans 30 villages (ZS Bonga Yasa et Kingandu) · 2 738 smartphones · 42 AS dotées en kits informatiques
Violences basées sur le genre	Comités locaux de lutte contre les VBG/EAS/HS ; sensibilisation et engagement communautaire ; prise en charge holistique des survivants ; kits PEP ; ligne verte	10 comités locaux · 30 formateurs · 30 prestataires cliniques · 2 500 pairs-éducateurs · 6 FOSA dotées en kits PEP
Participation communautaire	Mise en place et redynamisation des CAC, CODESA et UCODESA ; plans d'action communautaire ; micro-projets à impact nutritionnel ; financement basé sur la performance communautaire	938 CAC à créer · 1 044 CAC à redynamiser · 250 CODESA · 10 UCODESA · subvention de 300 USD par CAC
Services de nutrition dans les FOSA	PCIMA (UNTA/UNTI) ; CPSr ; CPN et CPoN ; promotion de l'ANJE ; SDE ; EHA ; gestion des intrants ; qualité des données	423 FOSA · 846 prestataires formés · 60 cadres d'ECZS · 10 UNTI réhabilitées · 250 dépôts aménagés
Coordination et gouvernance	Comité provincial et comités territoriaux multisectoriels de nutrition ; réunions trimestrielles des plateformes ; mécanismes de gestion des plaintes ; partenariat DPS/PRONANUT	2 ateliers provinciaux · 1 comité provincial · comités territoriaux (nombre non chiffré)

Composante	Interventions documentées dans Tech-4	Volumes et cibles du document source
Suivi-évaluation et apprentissage (RI 4.5)	Plan de suivi-évaluation ; MAA trimestriel ; évaluations de base, à mi-parcours et finale ; recherche opérationnelle ; documentation des bonnes pratiques ; revues semestrielles ; SNSAP	3 évaluations · MAA trimestriel · 2 sites sentinelles par ZS · forfait de 20 USD/mois par ZS pour le SNSAP

Les colonnes 1 et 2 reformulent des contenus de Tech-4 sans en modifier le sens ; la colonne 3 reprend les quantités explicitement écrites dans le document source.

1.6 Zones d'intervention et population cible

Les dix zones de santé ciblées se répartissent sur cinq territoires et la ville de Kikwit. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province, est excentrée et n'abrite aucune des dix zones de santé, mais le consortium y ouvre un sous-bureau pour des raisons stratégiques.

Tableau 5 — Répartition géographique et démographique des 10 zones de santé ciblées

Territoire / Ville	Zone de santé	Aires de santé	Villages	Ménages	CAC installées (2021)	Couverture CAC
Bagata	Sia	22	129	25 751	127	98 %
Bulungu	Djuma	35	226	50 652	226	100 %
Idiofa	Kimputu	28	237	45 962	232	98 %
Gungu	Gungu	31	393	58 219	262	67 %
Gungu	Kingandu	20	222	25 320	222	100 %
Kikwit	Kikwit Nord	25	833	54 506	72	9 %
Masi-Manimba	Pay Kongila	23	311	35 038	306	98 %
Masi-Manimba	Moanza	23	275	40 017	273	99 %
Masi-Manimba	Mosango	18	250	28 247	231	92 %
Masi-Manimba	Yasa Bonga	25	312	51 983	299	96 %
Total	**10 ZS**	**250**	**3 188**	**415 695**	**2 250**	**71 %**

Source : Tech-4, Tableau « Répartition et fonctionnalité des structures communautaires par ZS, DPS Kwilu 2021 ». Le besoin en relais communautaires est estimé à 8 314 RECO sur la base d'un ratio d'au plus 50 ménages par RECO.

SECTION 2

Théorie du changement et logique d'intervention

2.1 Le modèle Environnement – Demande – Offre (EDO) retenu par le consortium

Tech-4 fonde sa théorie du changement sur le modèle EDO, qui postule que « *seule une approche holistique d'interventions qui se renforcent mutuellement conduira à des programmes de santé et de développement durable* ». Les trois domaines — Offre, Environnement favorable et Demande — sont représentés comme « de manière égale, équivalente et interdépendante ».

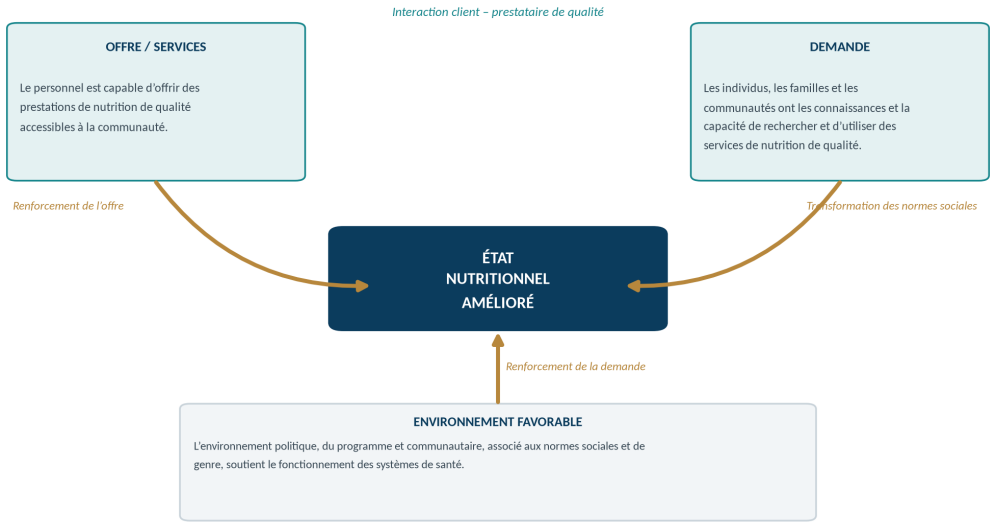


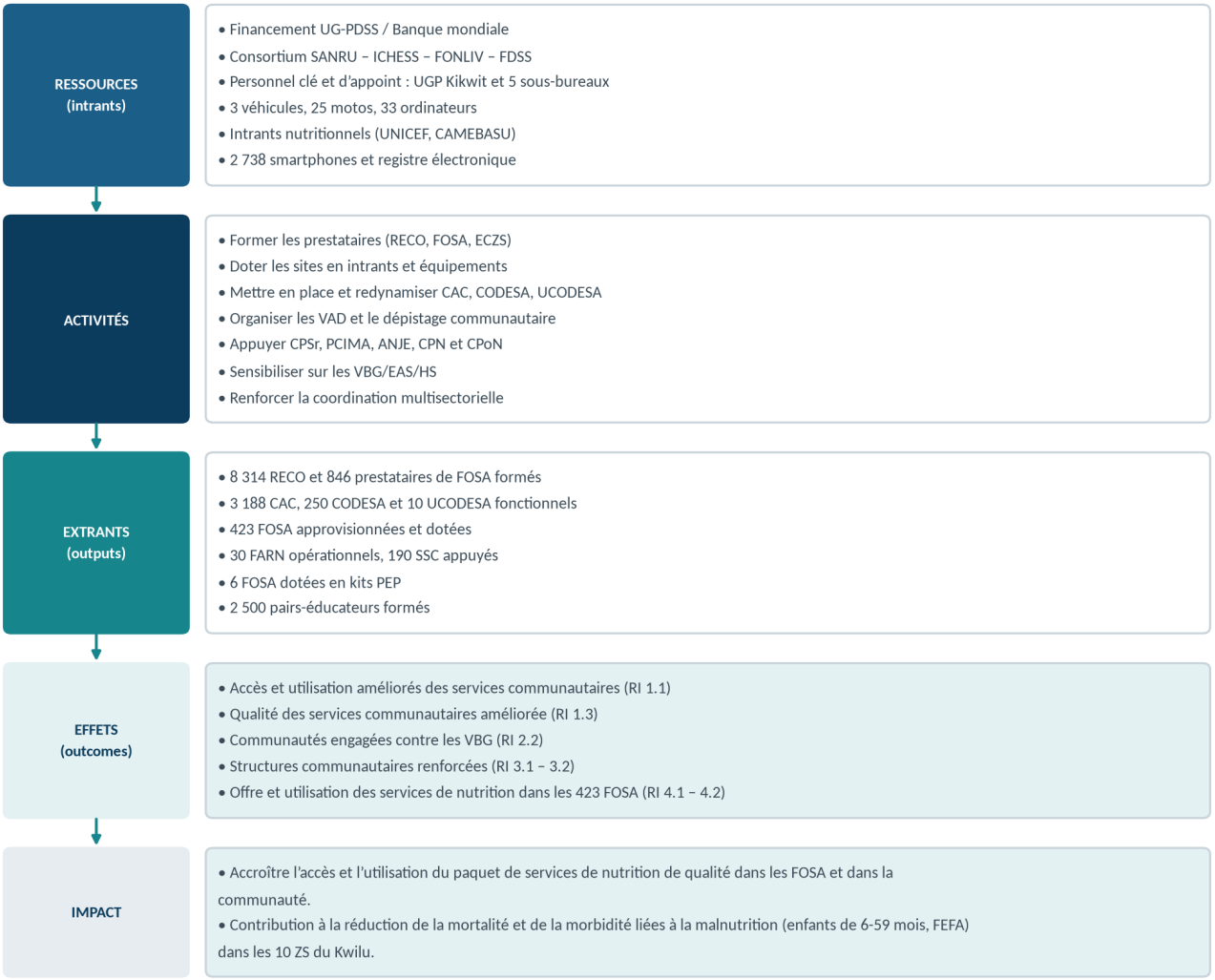
Figure 1 — Modèle EDO : Offre, Demande et Environnement favorable

Schéma reconstitué à partir de la description du modèle EDO dans Tech-4 (§1.5). Tech-4 renvoie également à une figure non reproduite dans le formulaire (« Figure xxx : Théorie de changement basée sur le modèle EDO »).

Le consortium précise que « *l'évaluation de départ « Baseline » […] pourra démontrer plus de problèmes pour l'un ou l'autre domaine par rapport aux autres* » et qu'il priorisera en conséquence les investissements. Ce point a une implication directe pour le suivi-évaluation : la ligne de base doit être désagrégée par domaine EDO afin de permettre cet arbitrage.

2.2 Chaîne des résultats

La chaîne des résultats est reconstituée ci-dessous à partir des objectifs, des résultats intermédiaires, du programme de travail et du cadre logique figurant dans Tech-4. Les volumes indiqués sont ceux du document source et non des cibles annuelles.



Logique reconstituée à partir de Tech-4. Les volumes indiqués sont ceux du document source.

Figure 2 — Chaîne des résultats : ressources → activités → extrants → effets → impact

Les liens de causalité entre extrants et effets sont ceux que Tech-4 énonce dans son cadre logique. Les relations non explicitées dans la source sont signalées en section 2.3.

2.3 Éléments de causalité à valider

Tableau 6 — Éléments de la théorie du changement à préciser

Élément de la logique	Statut dans Tech-4	Point à valider
Impact attendu sur le retard de croissance	L'objectif général cible « les principaux déterminants du retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans » ; le cadre logique mesure un volume de prise en charge	Établir la chaîne causale explicite entre le paquet de prise en charge et la prévalence du retard de croissance, et préciser si un indicateur de prévalence est suivi
Contribution des innovations (FARN, PB Famille)	Décrites et justifiées par des expériences antérieures (ACF Côte d'Ivoire 2015, FONLIV Vanga 2015, COOPI Boko 2017) ; RI 1.2 prévoit leur documentation	Définir les critères de succès des innovations et la mesure de leur effet sur la récupération des enfants MAM
Effet du volet VBG	Trois résultats intermédiaires (RI 2.1 à 2.3) et un I.O.V. de prise en charge holistique	Préciser le lien attendu entre sensibilisation, notification des cas et prise en charge effective
Financement basé sur la performance communautaire	Modèle annoncé (prime de 5 USD par RECO, 10 USD/mois par CAC) sans indicateurs de performance explicitement listés	Arrêter la liste des indicateurs de performance conditionnant les primes

Élément de la logique	Statut dans Tech-4	Point à valider
Durabilité	Principe directeur ; appui aux groupes de soutien limité aux 9 premiers mois ; micro-projets de 300 USD	Définir les indicateurs de pérennité (appropriation communautaire, maintien des CAC après le projet)

Ces points ne sont pas des lacunes du document source mais des éléments que le dispositif de suivi-évaluation doit clarifier pour être en mesure de démontrer les effets.

SECTION 3

Objectifs du système de suivi-évaluation

3.1 Objectif général du dispositif

Objectif général

Doter le consortium et ses partenaires d'un dispositif unique de mesure, d'analyse et de redevabilité permettant de vérifier, tout au long des exercices 2027 et 2028, l'atteinte des objectifs et des résultats intermédiaires définis dans Tech-4, d'éclairer la prise de décision et de rendre compte aux communautés, à la DPS/PRONANUT et à l'UG-PDSS.

3.2 Objectifs spécifiques

1. **Mesurer la mise en œuvre** : rendre compte de l'exécution du programme de travail de Tech-4 (activités, volumes de livrables, calendrier) selon une périodicité mensuelle et trimestrielle.
2. **Mesurer les résultats** : suivre les extrants et les effets au moyen des indicateurs du cadre de performance, avec des valeurs de référence établies par l'évaluation de base.
3. **Vérifier la qualité des services** : documenter la qualité des prestations communautaires et cliniques au moyen des outils d'évaluation développés avec le PRONANUT, des supervisions formatives et des enquêtes semestrielles de satisfaction.
4. **Assurer la qualité des données** : appliquer la triade complétude – promptitude – cohérence retenue par Tech-4, complétée par l'exactitude, et organiser des audits réguliers.
5. **Éclairer la décision** : produire des analyses exploitables lors des réunions de monitorage, du MAA, des revues semestrielles et des sessions du comité de pilotage.
6. **Rendre compte** : produire les rapports mensuels, trimestriels et annuels attendus par l'UG-PDSS, ainsi que les bulletins trimestriels de la DPS sur les données de nutrition.
7. **Capitaliser et apprendre** : documenter les bonnes pratiques, les innovations et les leçons apprises, et conduire la recherche opérationnelle prévue par Tech-4.

3.3 Besoins en information par niveau de décision

Tableau 7 — Besoins en information par niveau de décision

Niveau de décision	Besoins d'information	Périodicité	Support
Communauté (CAC, CODESA)	Couverture des cibles, réalisation des VAD, écarts entre cibles dénombrées et cibles servies, goulots d'étranglement locaux	Mensuelle (réunions de monitorage)	Registre électronique, BCP, tableau de bord communautaire
Aire de santé et centre de santé	Disponibilité des intrants, réalisation des activités, qualité des prestations, référencement	Mensuelle	Registres de FOSA, fiche de supervision, DHIS2
Zone de santé (ECZS)	Performance des AS, fonctionnalité des CAC/CODESA, qualité des données, gestion des intrants	Mensuelle et trimestrielle	DHIS2, rapports des AS, MAA
Province (DPS / PRONANUT)	Couverture des interventions traces, qualité des services, coordination multisectorielle	Trimestrielle et semestrielle	Bulletins trimestriels, revues semestrielles
Consortium (UGP)	Avancement du programme de travail, exécution budgétaire, risques, performances	Mensuelle et trimestrielle	Rapports d'avancement, tableau de bord de projet
Bailleur (UG-PDSS)	Atteinte des objectifs, résultats, redevabilité	Trimestrielle et annuelle	Rapports d'avancement trimestriels et annuels

Les périodicités reprennent celles que Tech-4 mentionne explicitement : réunions mensuelles de monitorage, supervisions mensuelles au niveau opérationnel, revues et supervisions trimestrielles aux niveaux provincial et national, revues semestrielles de la nutrition, rapports mensuels, trimestriels et annuels à l'UG-PDSS.

3.4 Utilisation des données pour la prise de décision

Tech-4 énonce que le dispositif doit permettre « *d'orienter la prise de décision basée sur des données fiables et de bonne qualité* » et prévoit explicitement que les résultats des évaluations alimentent les visites de supervision formative et de coaching. Le présent plan formalise quatre points d'entrée décisionnels : la réunion mensuelle de monitorage (action locale immédiate), le MAA trimestriel (suppression des goulots d'étranglement), la revue semestrielle (réorientation programmatique) et le comité de pilotage (arbitrage stratégique et budgétaire).

SECTION 4

Approche méthodologique

4.1 Architecture générale du dispositif

Le dispositif repose sur la combinaison de trois sources de données et de quatre temps de régulation. Les sources sont : (i) les **données de routine** du système national d'information sanitaire (DHIS2) alimentées par les FOSA ; (ii) les **registres communautaires**, papier puis électroniques, renseignés par les RECO et consolidés par les présidents de CAC ; (iii) les **enquêtes et évaluations** périodiques. Les temps de régulation sont le monitorage mensuel, le MAA trimestriel, la revue semestrielle et le comité de pilotage trimestriel.

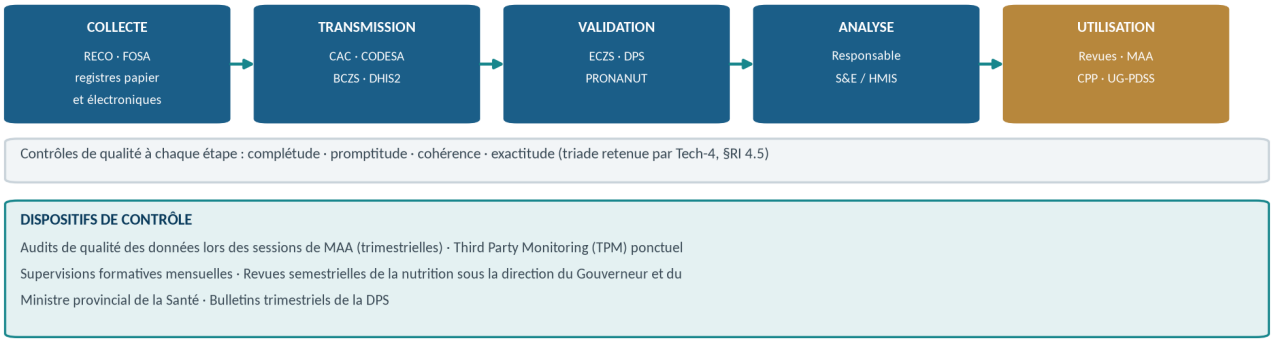


Figure 3 — Chaîne de valeur des données et dispositifs de contrôle

Les dispositifs de contrôle listés sont ceux que Tech-4 prévoit (§RI 4.2 et §RI 4.5).

4.2 Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre s'appuie sur le programme de travail de Tech-4 (section B.1), qui associe à chaque activité un livrable et un responsable. Le suivi consiste à renseigner, pour chaque activité, son état d'avancement, la date de réalisation, le volume produit et la preuve documentaire. Les livrables types identifiés par Tech-4 sont : rapport d'activité, rapport de formation et liste de présence, bon de livraison et procès-verbal de réception, preuve de paiement, compte rendu de réunion, cartographie, plan d'action et rapport de supervision.

> **Recommandation à valider**
>
> Adopter un référentiel unique d'activités codé selon la nomenclature de Tech-4 (1.1.1 à 5.9) et l'utiliser dans tous les rapports d'avancement, afin de garantir la traçabilité entre le programme de travail source et le suivi d'exécution. Tech-4 ne fournit pas ce référentiel sous forme de liste exhaustive : les codes cités dans le présent plan sont ceux qui figurent lisiblement dans le document.

4.3 Suivi des résultats

Le suivi des résultats s'organise autour des 14 résultats intermédiaires et de l'objectif global, mesurés par les 41 indicateurs du cadre de performance (section 6 et livrable 03). Chaque indicateur dispose d'une fiche technique précisant sa définition, sa formule, son unité, sa source de vérification, sa méthode et sa fréquence de collecte, son responsable de collecte et son responsable de validation.

Deux niveaux de mesure sont distingués : le **suivi continu** (indicateurs de routine, mensuels ou trimestriels) et le **suivi périodique** (indicateurs mesurés lors des enquêtes de base, à mi-parcours et finale). Cette distinction conditionne la planification de la section 9.

4.4 Suivi des indicateurs

Le suivi des indicateurs obéit à cinq règles : (i) un indicateur est toujours rattaché à un résultat intermédiaire de Tech-4 ; (ii) sa formule est documentée avant la première collecte ; (iii) sa valeur de référence est établie par l'évaluation de base et validée par la DPS/PRONANUT ; (iv) toute modification de définition est tracée et justifiée ; (v) aucune cible n'est fixée sans décision formelle des parties prenantes.

4.5 Évaluations périodiques

Tech-4 prévoit explicitement trois temps d'évaluation : **au début** (niveaux de départ des indicateurs), **à mi-parcours** (examen des processus) et **à la fin** (atteinte des objectifs et enseignements). L'évaluation initiale combine plusieurs thématiques : enquêtes SMART à grappes multiples, évaluation de la mise en place et de la fonctionnalité des organes de participation communautaire et des sites de soins communautaires, évaluation des services de nutrition et de prise en charge des VBG dans les FOSA, et évaluation des connaissances, attitudes et pratiques des communautés.

Tableau 8 — Évaluations et études prévues

Évaluation	Objet	Méthode prévue par Tech-4	Positionnement 2027–2028
Évaluation de base	Établir les niveaux de départ de tous les indicateurs et l'état des lieux des structures	Enquêtes transversales cliniques et communautaires ; SMART à grappes multiples ; évaluation de la fonctionnalité des CAC/CODESA ; CAP ; état des lieux des FOSA	1er trimestre 2027 *(proposition)*
Évaluation à mi-parcours	Examiner les processus et la trajectoire vers les résultats	Mêmes instruments, échantillon réduit ; revue documentaire ; entretiens avec les partenaires	4e trimestre 2027 *(proposition)*
Évaluation finale	Mesurer l'atteinte des objectifs et tirer les enseignements	Combinaison des instruments de l'évaluation de base ; critères de pertinence, d'efficacité et de pérennité	4e trimestre 2028 *(proposition)*
Recherche opérationnelle	Documenter les innovations et les questions de mise en œuvre	Protocole validé et approuvé par le comité d'éthique de l'École de Santé Publique ; publication	Continu, avec points d'étape semestriels *(proposition)*
Évaluations de la qualité de prise en charge	Apprécier la qualité des soins et services de nutrition	Cadre global d'évaluation de la qualité, auto-évaluation, outil « Quality Health Scaling »	Trimestriel *(proposition)*

*Tech-4 fixe les trois temps d'évaluation et leurs méthodes, mais **ne précise pas leur calendrier** au-delà de « début / mi-parcours / fin ». Le positionnement annuel proposé est donc une recommandation à valider.*

4.6 Collecte quantitative et qualitative

La collecte quantitative s'appuie sur les registres de routine et sur les enquêtes. La collecte qualitative mobilise les focus groups, les dialogues communautaires, les entretiens avec les parties prenantes et l'observation directe lors des visites à domicile. Tech-4 prévoit expressément des focus groups réguliers *« pour permettre de collecter les attentes, les craintes des clientes et proposer des solutions adaptées à leurs besoins »*, ainsi que des formulaires de supervision dédiés (observation d'une VAD intégrée et ciblée, évaluation de cas par vérification inopinée, spot check dans les ménages).

4.7 Triangulation des informations

Tableau 9 — Matrice de triangulation des sources

Question de mesure	Source 1	Source 2	Source 3
Couverture des interventions	DHIS2 (FOSA)	Registre électronique communautaire	Enquête SMART / CAP
Qualité des services	Grille d'évaluation de la qualité	Supervision formative	Enquête de satisfaction
Fonctionnalité des CAC/CODESA	Rapports de réunions mensuelles	Cartographie actualisée	Évaluation de la fonctionnalité
Données communautaires	Registre du RECO	Consolidation PrésiCAC	Third Party Monitoring (TPM)
Cas de VBG	Registres des FOSA	DHIS2	Rapports du sous-cluster VBG

Les sources 1 à 3 sont toutes mentionnées par Tech-4. Le recours au TPM est explicitement prévu pour tracer « les parallélismes entre les données récoltées par les RECO [et] celles des enquêtes ad hoc ».

4.8 Assurance qualité des données

Tech-4 retient explicitement la « *triade formelle de la qualité des données à savoir : la complétude, la promptitude et la cohérence* ». Le présent plan la complète par l'exactitude, la validité et la traçabilité, et organise les contrôles décrits à la section 8.

4.9 Documentation et capitalisation

Tech-4 prévoit la documentation des bonnes pratiques, des innovations et des leçons apprises, ainsi qu'un système d'apprentissage et d'échange entre les dix zones de santé. La capitalisation s'appuiera sur les constats du MAA et des revues semestrielles, sur les rapports d'évaluation et sur les productions de la recherche opérationnelle.

SECTION 5

Dispositif de suivi des indicateurs

Le registre ci-après recense l'ensemble des indicateurs mobilisables à partir de Tech-4. Il constitue la base du cadre de performance (livrable 03). Chaque indicateur est rattaché à un objectif et à un résultat intermédiaire, et sa traçabilité documentaire est indiquée en dernière colonne.

> **Comment lire les valeurs**
>
> **Valeurs en caractères normaux** : information explicitement présente dans Tech-4.
> **« À préciser » en rouge** : information absente du document source — elle sera produite par l'évaluation de base ou arrêtée lors de l'atelier de validation des cibles.
> **« Cible globale »** : volume fixé par Tech-4 pour l'ensemble de la durée du projet, sans ventilation annuelle.

Avertissement sur les cibles annuelles. Tech-4 ne comporte aucune cible annuelle. Les colonnes « Cible 2027 » et « Cible 2028 » sont donc systématiquement renseignées « À préciser ». Le report de la « cible globale » dans l'une ou l'autre année constituerait une construction non documentée : elle n'est pas effectuée ici. La procédure d'arbitrage est décrite en section 5.3.

5.1 Registre des indicateurs — vue matricielle

Le tableau ci-après présente les 14 colonnes demandées. En raison de sa largeur, il est présenté en format paysage et décomposé en trois vues complémentaires (identification, mesure, gouvernance) afin de rester parfaitement lisible.

Tableau 10 — Registre des indicateurs (vue 1/3) : identification et définition

Code	Objectif	Résultat attendu	Indicateur	Définition
IMP-01	OG	Objectif global — niveau impact	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition	Nombre cumulé d'enfants de moins de 5 ans ayant reçu l'ensemble des composantes du paquet de prise en charge de la malnutrition aiguë (dépistage, admission, traitement, suivi jusqu'au déchargement) dans les FOSA et/ou la communauté des 10 ZS.
IMP-02	OG	Indicateur de contexte (proposition)	Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu	Proportion d'enfants de moins de 5 ans dont le rapport taille-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.
EFF-01	OG	Objectif global — I.O.V.	Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC	Proportion de villages (rues/localités) des 10 ZS dans lesquels il existe simultanément une Cellule d'Animation Communautaire fonctionnelle et la mise en œuvre effective des activités de Nutrition à Assise Communautaire.
EFF-02	OG	Objectif global — I.O.V.	Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	Nombre et proportion de survivants de violences sexuelles (SVS) orientés et effectivement pris en charge selon le paquet holistique (médical, psychosocial et juridique) parmi les cas identifiés dans les 10 ZS.
EFF-03	OG	Objectif global — I.O.V.	Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle	Proportion d'entités administratives décentralisées (province, territoires, zones de santé) disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition (comité provincial ou comité territorial multisectoriel) effectivement fonctionnelle.

Code	Objectif	Résultat attendu	Indicateur	Définition
EFF-04	OG	Objectif global — I.O.V.	Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition	Proportion de formations sanitaires (FOSA) des 10 ZS offrant simultanément les interventions CPN, CPoN, ANJE, CPSr et PCIMA, sans rupture d'intrants nutritionnels au cours de la période de référence.
EFF-05	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel	Proportion d'enfants nés vivants mis au sein dans l'heure suivant la naissance.
EFF-06	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois	Proportion d'enfants de 0 à 5 mois (0-23 semaines) exclusivement allaités au sein, sans autre liquide ni solide, hors médicaments.
EFF-07	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)	Proportion d'enfants de 6 à 23 mois recevant une alimentation de complément conforme aux critères « 4 étoiles » (qualité, quantité, fréquence et utilisation d'aliments locaux enrichis) promus par le projet.
EFF-08	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux	Proportion d'enfants de 6-23 mois supplémentaires en micronutriments en poudre (MNPs) dont le taux d'hémoglobine est inférieur au seuil d'anémie défini par l'OMS pour l'âge.
EFF-09	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois ayant reçu une dose de vitamine A au cours des six derniers mois.
EFF-10	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois	Proportion d'enfants de 12 à 59 mois ayant reçu une dose de Mébendazole/Albendazole au cours des six derniers mois.
EFF-11	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois	Proportion d'enfants de 0 à 23 mois dont le poids-pour-âge se situe à moins de −2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence OMS.
EFF-12	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques	Proportion de ménages ciblés où le lavage des mains à l'eau et au savon est pratiqué aux moments critiques (avant la préparation des repas, avant de manger, après les latrines, avant de nourrir l'enfant).
EFF-13	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition	Proportion de ménages ciblés ayant adopté les trois autres pratiques familiales essentielles (PFE) relatives à la nutrition promues par le projet, en complément du lavage des mains.
EFF-14	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus	Proportion de femmes enceintes ayant effectué au moins quatre consultations prénatales au cours de la grossesse.
EFF-15	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager	Proportion d'écoles appuyées par le projet disposant d'un jardin potager fonctionnel.
EFF-16	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire	Proportion de ménages ciblés dont le score de diversification alimentaire (nombre de groupes d'aliments consommés) atteint le seuil optimal défini avec le PRONANUT.
EFF-17	OS2	RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG	Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS	Nombre cumulé de séances de sensibilisation et d'engagement communautaire sur les VBG/EAS/HS réalisées dans les 10 ZS (émissions radio, focus groups, campagnes, causeries).
EFF-18	OS2	RI 2.1 — Comités locaux de lutte contre les VBG/EAS/HS mis en place et actifs	Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel	Proportion de ZS dans lesquelles un comité local de lutte contre les VBG/EAS/HS est mis en place et tient ses réunions selon la périodicité prévue.
EFF-19	OS4	RI 4.1 — Offre et utilisation des services de nutrition dans les 423 formations sanitaires améliorées	Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère	Proportion d'enfants de 6 à 59 mois référés dans les unités nutritionnelles (UNTA/UNTI) pour malnutrition aiguë sévère qui sont effectivement admis et pris en charge.
EXT-01	OS3	RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés	Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	Nombre cumulé de Cellules d'Animation Communautaire (CAC), de Comités de Développement Sanitaire (CODESA) et d'Unions de CODESA (UCODESA) créés ou redynamisés et rendus fonctionnels dans les villages/rues et aires de santé des 10 ZS.
EXT-02	OS3	RI 3.1 — Organisation et fonctionnement des structures de participation communautaire renforcés	Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels	Proportion de structures de participation communautaire (CAC, CODESA, UCODESA) qui remplissent les critères de fonctionnalité normatifs du MSPHP (tenue des réunions mensuelles, existence et mise en œuvre d'un plan d'action communautaire, rapportage).
EXT-03	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Nombre de relais communautaires (RECO) formés	Nombre cumulé de relais communautaires ayant achevé la formation initiale sur le paquet NAC (dynamique communautaire, PFE, résilience, surveillance à base communautaire, ANJE, CPSr, PCIMA, VBG, outils de collecte).

Code	Objectif	Résultat attendu	Indicateur	Définition
EXT-04	OS4	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires améliorée	Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel	Nombre cumulé de prestataires des formations sanitaires formés ou recyclés sur le paquet nutritionnel (PCIMA, CPSr, ANJE et PFE, gestion des intrants, VBG, gestion des déchets, outils de gestion des données, COVID-19).
EXT-05	OS4	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires améliorée	Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés	Nombre cumulé de membres des ECZS des 10 ZS formés sur le paquet nutritionnel et la supervision formative.
EXT-06	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés	Nombre de sites de soins communautaires appuyés par le projet et dotés en matériels, outils de prestation et intrants (bâton de screening, MUAC, balance, registre, boîte à images, carte conseil, carnet de jeton d'orientation).
EXT-07	OS4	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires améliorée	Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion	Nombre cumulé de formations sanitaires ayant reçu les intrants nutritionnels (ATPE, F-75, F-100, vitamine A, Mébendazole, fer, MNPs, MMS, SRO/Zinc) et les outils de gestion (registres, fiches, protocoles).
EXT-08	OS1	RI 1.2 — Mise en place et documentation des approches innovantes pour renforcer la lutte durable contre la malnutrition aiguë	Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels	Nombre de FARN opérationnels dans les villages ciblés, assurant la réhabilitation des enfants atteints de malnutrition aiguë modérée à partir d'aliments locaux.
EXT-09	OS4	RI 4.2 — Qualité du service de nutrition dans les 423 formations sanitaires améliorée	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques intensives (UNTI) réhabilitées et nombre de dépôts d'intrants nutritionnels aménagés au niveau des FOSA mères des aires de santé.
EXT-10	OS2	RI 2.3 — Système de prestation de services de prise en charge des SVS renforcé	Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS	Nombre de formations sanitaires des zones non appuyées par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dotées en kits PEP et intrants spécifiques pour la prise en charge médicale des survivants de violences sexuelles.
EXT-11	OS2	RI 2.2 — Communautés sensibilisées et engagées dans la lutte contre les VBG	Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS	Nombre cumulé de formateurs provinciaux, de prestataires cliniques et de jeunes pairs-éducateurs formés ou recyclés sur la prévention et la prise en charge des VBG/EAS/HS.
EXT-12	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés	Nombre cumulé d'émissions radio de sensibilisation/éducation nutritionnelle (ANJE, EHA, VBG) diffusées dans les 10 ZS et nombre de spots conçus et diffusés.
EXT-13	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre	Nombre de CAC et de CODESA disposant d'un plan d'action communautaire élaboré à partir d'un diagnostic communautaire et effectivement mis en œuvre.
EXT-14	OS3	RI 3.2 — Leadership et capacités managériales locales des structures de participation communautaire renforcés	Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire	Nombre de CAC dotées de smartphones équipés du registre communautaire électronique et du dispositif de monitorage en temps réel, et opérationnelles.
EXT-15	OS3	RI 3.3 — Coordination, collaboration multisectorielle et mécanismes de suivi des interventions renforcés	Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)	Nombre de comités provinciaux et territoriaux multisectoriels de nutrition effectivement installés, dotés d'un mandat et d'un calendrier de réunions.
EXT-16	OS1	RI 1.1 — Accès et utilisation améliorés des services communautaires de nutrition et de santé	Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel	Nombre d'écoles ayant reçu l'appui du projet (forfait semences et matériel aratoire, formations pratiques) et disposant d'un jardin potager fonctionnel.
REA-01	OS5	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium	Proportion de rapports d'activité mensuels attendus effectivement reçus et complets pour les FOSA et les structures communautaires des 10 ZS.
REA-02	OS5	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2	Proportion de rapports mensuels transmis dans le délai normé au niveau du BCZS puis saisis dans DHIS2.
REA-03	OS5	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées	Nombre cumulé de sessions de MAA tenues au niveau communautaire, des centres de santé et des zones de santé avec les parties prenantes.
REA-04	OS5	RI 4.5 — Système de suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage des activités de nutrition assuré	Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)	Nombre cumulé d'évaluations et d'études réalisées et documentées : évaluation de base, évaluation à mi-parcours, évaluation finale, recherche opérationnelle et évaluations de la qualité de prise en charge.

Objectifs : OG = objectif global ; OS1 à OS4 = objectifs spécifiques ; OS5 = RI 4.5 (suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage). Les libellés des résultats intermédiaires sont ceux de Tech-4.

Tableau 11 — Registre des indicateurs (vue 2/3) : mesure, référence et cibles

Code	Indicateur	Méthode de calcul	Unité	Valeur de référence	Cible 2027	Cible 2028	Cible globale Tech-4
IMP-01	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition	**Formule :** Décompte cumulé des enfants de moins de 5 ans enregistrés comme ayant bénéficié du paquet holistique de prise en charge de la malnutrition sur la période. **Numérateur :** Enfants < 5 ans ayant bénéficié du paquet holistique de PEC **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre d'enfants	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
IMP-02	Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu	**Formule :** (Enfants de 0-59 mois avec un z-score taille-pour-âge < −2 ET / Nombre total d'enfants de 0-59 mois mesurés et pesés) × 100 **Numérateur :** Enfants 0-59 mois avec z-score T/A < −2 ET **Dénominateur :** Enfants 0-59 mois mesurés et pesés	Pourcentage	47 % (province du Kwilu, enfants < 5 ans ; Tech-4 §1.1, citant MICS-Palu 2017-2018 / MICS 6)	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-01	Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC	**Formule :** (Villages avec CAC fonctionnelle ET activités NAC / Nombre total de villages des 10 ZS) × 100 **Numérateur :** Villages avec CAC fonctionnelle et activités NAC **Dénominateur :** Nombre total de villages des 10 ZS (3 188 selon DPS Kwilu 2021)	Pourcentage	71 % de couverture en CAC installées (2 250/3 188 villages, DPS Kwilu 2021) ; 53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles en 2021 (DHIS2). La proportion combinée « CAC fonctionnelle + activités NAC » n'est pas renseignée dans Tech-4.	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-02	Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	**Formule :** (Survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une PEC holistique / Nombre de survivants de violences sexuelles identifiés) × 100 **Numérateur :** SVS ayant bénéficié d'une PEC holistique **Dénominateur :** SVS identifiés dans les 10 ZS sur la période	Nombre et pourcentage	1,9 % des survivants de VBG globalement pris en charge au 3e trimestre 2021 (contre 1,3 % au 3e trimestre 2020) — Tech-4 §1.2 OS2. Tech-4 ne précise pas le niveau géographique exact de cette statistique (données du sous-cluster VBG).	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-03	Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle	**Formule :** (Entités administratives avec plate-forme multisectorielle fonctionnelle / Nombre total d'entités administratives décentralisées ciblées) × 100 **Numérateur :** Entités avec plate-forme fonctionnelle **Dénominateur :** Entités administratives décentralisées ciblées (nombre à préciser : 1 province, 5 territoires, 10 ZS selon Tech-4)	Pourcentage	Non mis en place : Tech-4 indique que « ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » (§RI 3.3)	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-04	Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition	**Formule :** (FOSA offrant CPN + CPoN + ANJE + CPSr + PCIMA sans rupture d'intrants / Nombre total de FOSA des 10 ZS) × 100 **Numérateur :** FOSA avec paquet complet et sans rupture **Dénominateur :** 423 FOSA des 10 ZS (Tech-4 : 413 CS abritant les UNTA + 10 HGR abritant les UNTI)	Pourcentage	Couverture des interventions dans les 10 ZS (PRONANUT Kwilu 2020, cité par Tech-4) : CPSr 47,1 % ; ANJE 50 % ; PCIMA 0 % ; NAC 0 %. Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrants nutritionnels depuis 2019. La proportion de FOSA offrant le paquet complet n'est pas renseignée.	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-05	Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel	**Formule :** (Enfants de moins de 24 mois mis au sein dans l'heure suivant la naissance / Nombre total d'enfants de moins de 24 mois) × 100 **Numérateur :** Enfants mis au sein dans l'heure **Dénominateur :** Enfants de moins de 24 mois	Pourcentage	29,2 % dans la province du Kwilu (contre 46,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-06	Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois	**Formule :** (Enfants de 0-5 mois exclusivement allaités / Nombre total d'enfants de 0-5 mois) × 100 **Numérateur :** Enfants de 0-5 mois exclusivement allaités **Dénominateur :** Enfants de 0-5 mois	Pourcentage	32,7 % dans la province du Kwilu (contre 53,5 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*

Code	Indicateur	Méthode de calcul	Unité	Valeur de référence	Cible 2027	Cible 2028	Cible globale Tech-4
EFF-07	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)	**Formule :** (Enfants de 6-23 mois avec alimentation de complément adéquate / Nombre total d'enfants de 6-23 mois) × 100 **Numérateur :** Enfants 6-23 mois avec alimentation de complément adéquate **Dénominateur :** Enfants 6-23 mois	Pourcentage	Environ 18 % d'enfants de 6-23 mois bénéficient correctement d'une alimentation de complément ; 27,1 % reçoivent une diversité alimentaire minimale et près de la moitié (47 %) un repas à fréquence minimale — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-08	Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux	**Formule :** (Enfants de 6-23 mois anémiés parmi ceux supplémentés en MNPs / Nombre d'enfants de 6-23 mois supplémentés et testés) × 100 **Numérateur :** Enfants 6-23 mois anémiés (supplémentés) **Dénominateur :** Enfants 6-23 mois supplémentés et testés	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-09	Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois	**Formule :** (Enfants de 6-59 mois ayant reçu une dose de vitamine A / Nombre total d'enfants de 6-59 mois) × 100 **Numérateur :** Enfants 6-59 mois supplémentés en vitamine A **Dénominateur :** Enfants 6-59 mois	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-10	Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois	**Formule :** (Enfants de 12-59 mois déparasités / Nombre total d'enfants de 12-59 mois) × 100 **Numérateur :** Enfants 12-59 mois déparasités **Dénominateur :** Enfants 12-59 mois	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-11	Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois	**Formule :** (Enfants 0-23 mois avec z-score P/A < −2 ET / Nombre total d'enfants 0-23 mois pesés) × 100 **Numérateur :** Enfants 0-23 mois avec z-score P/A < −2 ET **Dénominateur :** Enfants 0-23 mois pesés	Pourcentage	34,8 % d'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu — Tech-4 §1.1 (la valeur spécifique aux 0-23 mois n'est pas renseignée)	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-12	Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques	**Formule :** (Ménages pratiquant le lavage des mains aux moments critiques / Nombre de ménages enquêtés) × 100 **Numérateur :** Ménages pratiquant le lavage des mains aux moments critiques **Dénominateur :** Ménages enquêtés	Pourcentage	18 % des ménages disposent d'une installation de lavage des mains où l'eau et le savon sont présents — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-13	Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition	**Formule :** (Ménages ayant adopté les 3 PFE / Nombre de ménages ciblés enquêtés) × 100 **Numérateur :** Ménages ayant adopté les 3 PFE **Dénominateur :** Ménages ciblés enquêtés	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-14	Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus	**Formule :** (Femmes enceintes avec ≥ 4 CPN / Nombre total de femmes enceintes ayant accouché sur la période) × 100 **Numérateur :** Femmes enceintes avec ≥ 4 CPN **Dénominateur :** Femmes ayant accouché sur la période	Pourcentage	24,3 % dans la province du Kwilu (contre 42,9 % au niveau national) — Tech-4 §1.1	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-15	Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager	**Formule :** (Écoles avec jardin potager fonctionnel / Nombre d'écoles appuyées) × 100 **Numérateur :** Écoles avec jardin potager fonctionnel **Dénominateur :** Écoles appuyées (30 écoles prévues pour les 10 ZS)	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-16	Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire	**Formule :** (Ménages avec score de diversification optimal / Nombre de ménages enquêtés) × 100 **Numérateur :** Ménages avec score optimal **Dénominateur :** Ménages enquêtés	Pourcentage	27,1 % d'enfants reçoivent une diversité alimentaire minimale — Tech-4 §1.1. Le score de diversification au niveau des ménages n'est pas renseigné.	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*

Code	Indicateur	Méthode de calcul	Unité	Valeur de référence	Cible 2027	Cible 2028	Cible globale Tech-4
EFF-17	Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS	**Formule :** Décompte cumulé des séances de sensibilisation documentées (compte rendu et liste de présence). **Numérateur :** Séances de sensibilisation réalisées **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre de séances	26,5 % au 3e trimestre 2021 contre 9,9 % au 3e trimestre 2020 (indicateur d'amélioration du nombre de séances, Tech-4 §1.2 OS2)	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-18	Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel	**Formule :** (ZS avec comité local fonctionnel / 10 ZS ciblées) × 100 **Numérateur :** ZS avec comité local fonctionnel **Dénominateur :** 10 ZS ciblées	Pourcentage	Non renseigné. Tech-4 indique que « ces informations ne permettent pas d'établir une cartographie d'intervenants dans le domaine de VBG/EAS/HS » et que 4 ZS (Kimputu, Moanza, Pay Kongila, Sia) sont « restées silencieuses » pour toute la période 2021 (DHIS2).	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
EFF-19	Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère	**Formule :** (Enfants MAS référés et pris en charge / Enfants MAS référés) × 100 **Numérateur :** Enfants MAS référés et pris en charge **Dénominateur :** Enfants MAS référés	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	≥ 80 %	*À préciser*
EXT-01	Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	**Formule :** Décompte cumulé des CAC + CODESA + UCODESA mis en place ou redynamisés, attesté par la cartographie actualisée et les procès-verbaux d'assemblée villageoise et d'investiture. **Numérateur :** CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	2 250 CAC installées (couverture 71 % de 3 188 villages) et 250 CODESA (couverture 100 % des AS) — DPS Kwilu 2021, cité par Tech-4 ; 938 villages sans CAC.	*À préciser*	*À préciser*	3 188 CAC (dont 938 nouvelles CAC à mettre en place et 1 044 CAC à redynamiser), 250 CODESA et 10 UCODESA (Tech-4 §RI 3.1)
EXT-02	Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels	**Formule :** (Structures fonctionnelles / Structures mises en place ou redynamisées) × 100 **Numérateur :** CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels **Dénominateur :** CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	Pourcentage	53,6 % des CAC ont tenu toutes leurs réunions mensuelles de monitorage en 2021 (DHIS2) ; 16 % seulement des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire contre 30 % au niveau national (Tech-4 §OS3)	*À préciser*	*À préciser*	Non chiffrée par Tech-4 (aucun pourcentage cible n'est fixé)
EXT-03	Nombre de relais communautaires (RECO) formés	**Formule :** Décompte cumulé des RECO ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence et le rapport de formation. **Numérateur :** RECO formés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	8 314 RECO nécessaires pour 415 695 ménages (1 RECO pour 50 ménages) ; couverture actuelle non renseignée	*À préciser*	*À préciser*	8 314 RECO (4 956 RECO prévus dans les TDR comme cible totale, formation étendue aux 3 358 restants pour assurer la couverture totale) — Tech-4 §Objectif 1
EXT-04	Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel	**Formule :** Décompte cumulé des prestataires ayant achevé la formation, attesté par les listes de présence. **Numérateur :** Prestataires de FOSA formés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Les formations PCIMA, NAC, ANJE et CPSr dans les 10 ZS datent de plus de 4 ans ; 27 % de jours de disponibilité d'un personnel formé en PCIMA au Kwilu contre 37 % au niveau national (MAA 2016, cité par Tech-4)	*À préciser*	*À préciser*	846 personnes, soit 2 prestataires par FOSA pour les 423 FOSA (Tech-4 §RI 4.2 : « un total 8 46 personnes en raison de deux prestataires par FOSA »)
EXT-05	Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés	**Formule :** Décompte cumulé des membres d'ECZS ayant achevé la formation. **Numérateur :** Membres d'ECZS formés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	60 personnes, soit 6 personnes par ECZS (MCZS, MDH, DN, Nutritionniste, AC et 1 IS) pour les 10 ECZS — Tech-4 §RI 4.2
EXT-06	Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés	**Formule :** Décompte des SSC ayant reçu la dotation complète, attesté par les bordereaux de livraison et PV de réception. **Numérateur :** SSC dotés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	190 sites de soins communautaires répartis dans les 10 ZS (Tech-4 §Objectif 1)	*À préciser*	*À préciser*	190 SSC (Tech-4 §Objectif 1)

Code	Indicateur	Méthode de calcul	Unité	Valeur de référence	Cible 2027	Cible 2028	Cible globale Tech-4
EXT-07	Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion	**Formule :** Décompte des FOSA ayant reçu au moins une dotation complète sur la période, attesté par les bons de réception. **Numérateur :** FOSA approvisionnées **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Aucune ZS de la province n'a été approvisionnée en intrant nutritionnel depuis 2019 — Tech-4 §RI 4.1	*À préciser*	*À préciser*	423 FOSA (413 CS et 10 HGR) — Tech-4 §RI 4.2
EXT-08	Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels	**Formule :** Décompte des FARN ayant accueilli des enfants et fonctionné au moins un cycle de 15 jours sur la période. **Numérateur :** FARN fonctionnels **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Aucun FARN n'existe dans les 10 ZS : il s'agit d'une innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 1.2)	*À préciser*	*À préciser*	30 FARN, soit 1 par village, dans 30 villages de 2 ZS (Bonga Yasa et Kingandu) — Tech-4 §RI 1.2
EXT-09	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés	**Formule :** Décompte des UNTI réhabilitées et des dépôts aménagés, attesté par les rapports de réception des travaux. **Numérateur :** UNTI réhabilitées + dépôts aménagés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	« Aucune structure ne dispose des conditions adéquates de conservation des intrants nutritionnels » — Third Party Monitoring FDSS 2020-2021, cité par Tech-4 §RI 4.2	*À préciser*	*À préciser*	10 UNTI réhabilitées et 250 dépôts aménagés — Tech-4 §RI 4.2
EXT-10	Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS	**Formule :** Décompte des FOSA ayant reçu les kits PEP et intrants, attesté par les bons d'expédition et PV de réception. **Numérateur :** FOSA dotées en kits PEP **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Stock de kits PEP porté par le Fonds mondial/CORDAID/FDSS dans 8 ZS ; aucune dotation dans les 2 ZS non appuyées (Kimputu et Gungu) — Tech-4 §OS2	*À préciser*	*À préciser*	6 FOSA, soit 3 par ZS dans les 2 ZS non appuyées (Kimputu et Gungu) — Tech-4 §OS2
EXT-11	Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS	**Formule :** Décompte cumulé des personnes formées, attesté par les listes de présence (désagrégé par catégorie). **Numérateur :** Personnes formées VBG/EAS/HS **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	30 formateurs provinciaux/zonaux + 30 prestataires cliniques + 2 500 jeunes pairs-éducateurs (10 par AS dans 250 AS) — Tech-4 §OS2 et §RI 2.3
EXT-12	Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés	**Formule :** Décompte des émissions et diffusions attesté par les rapports de monitorage de la diffusion et les contrats de diffusion. **Numérateur :** Émissions et spots diffusés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Cinq radios couvrent chacune au moins 2 des 10 ZS ciblées (Tech-4 §Objectif 1) ; aucun volume antérieur renseigné	*À préciser*	*À préciser*	150 émissions radio (1 émission/ZS/15 mois) ; 10 spots ANJE/PFE conçus et traduits ; 3 spots VBG/EAS/HS — Tech-4 §Objectif 1 et §OS2
EXT-13	Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre	**Formule :** Décompte des PAC validés et des preuves de mise en œuvre (rapports d'activité, preuves de paiement des micro-projets). **Numérateur :** CAC et CODESA avec PAC mis en œuvre **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	16 % des CAC du Kwilu disposaient d'un plan d'action communautaire (contre 30 % au niveau national) — Plan stratégique national de santé communautaire 2019-2022, cité par Tech-4 §OS3	*À préciser*	*À préciser*	3 188 CAC et 250 CODESA — Tech-4 §RI 3.1
EXT-14	Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire	**Formule :** Décompte des smartphones déployés et des CAC transmettant des données via le registre électronique. **Numérateur :** CAC équipées et opérationnelles **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Aucun registre électronique communautaire en place : innovation introduite par le projet (Tech-4 §RI 3.2)	*À préciser*	*À préciser*	2 738 smartphones avec registre électronique pour les RECO et PrésiCAC ; 1 083 CAC connectées par un forfait internet (2 Go/mois) — Tech-4 §RI 3.2
EXT-15	Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)	**Formule :** Décompte des comités installés, attesté par les rapports de mise en place, les arrêtés et les comptes rendus de réunions. **Numérateur :** Comités multisectoriels installés **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	« Ces comités ne sont pas encore mis en place au niveau de la Province de Kwilu » — Tech-4 §RI 3.3	*À préciser*	*À préciser*	1 comité provincial et des comités territoriaux aux niveaux ZS et territoires (nombre exact non chiffré dans Tech-4)

Code	Indicateur	Méthode de calcul	Unité	Valeur de référence	Cible 2027	Cible 2028	Cible globale Tech-4
EXT-16	Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel	**Formule :** Décompte des écoles appuyées et vérification de la fonctionnalité du jardin. **Numérateur :** Écoles avec jardin potager fonctionnel **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	30 écoles pour les 10 ZS — Tech-4 §Objectif 1
REA-01	Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium	**Formule :** (Rapports mensuels reçus et complets / Rapports mensuels attendus) × 100 **Numérateur :** Rapports reçus et complets **Dénominateur :** Rapports attendus	Pourcentage	Non renseigné dans Tech-4 : le document évoque une « faible complétude, promptitude et exactitude des données » (PNDS 2019-2022, cité §RI 4.2) sans fournir de valeur	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
REA-02	Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2	**Formule :** (Rapports transmis dans les délais / Rapports attendus) × 100 **Numérateur :** Rapports transmis dans les délais **Dénominateur :** Rapports attendus	Pourcentage	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*	*À préciser*
REA-03	Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées	**Formule :** Décompte cumulé des sessions MAA documentées par compte rendu. **Numérateur :** Sessions MAA réalisées **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre de sessions	Dispositif non encore en place : à introduire par le projet (Tech-4 §RI 4.5)	*À préciser*	*À préciser*	Sessions trimestrielles au niveau de la communauté, des centres de santé et des zones de santé (Tech-4 §RI 4.5) — nombre total non chiffré
REA-04	Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)	**Formule :** Décompte des rapports d'évaluation et d'étude validés. **Numérateur :** Évaluations et études réalisées **Dénominateur :** Sans objet (indicateur de volume)	Nombre	Aucune évaluation antérieure documentée pour le projet (démarrage)	*À préciser*	*À préciser*	3 évaluations (début, mi-parcours, fin) + recherche opérationnelle + évaluations de la qualité de prise en charge (Tech-4 §RI 4.5)

Aucune cible annuelle n'est documentée dans Tech-4. La colonne « Cible globale Tech-4 » reproduit, lorsqu'il existe, le volume fixé par le document source pour l'ensemble de la durée du projet.

Tableau 12 — Registre des indicateurs (vue 3/3) : sources, méthodes et responsabilités

Code	Indicateur	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable de collecte	Responsable de validation
IMP-01	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ayant bénéficié d'un paquet holistique de prise en charge de la malnutrition	Rapports programmatiques du projet ; rapports périodiques du PRONANUT (Tech-4, cadre logique)	Extraction DHIS2 (registres UNTA/UNTI et registres communautaires) ; consolidation par les BCZS ; triangulation avec les rapports d'enquête	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
IMP-02	Prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu	Enquête SMART de l'évaluation de base et de l'évaluation finale (Tech-4, RI 4.5)	Enquête anthropométrique par grappes (SMART) — mesure du z-score taille-pour-âge	Début et fin de programme (Tech-4 : évaluations de base et finale)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-01	Proportion de villages disposant à la fois d'une CAC fonctionnelle et des activités de NAC	Cartographie actualisée des CAC ; rapports périodiques des ZS ; DHIS2 ; rapport de l'évaluation de base (Tech-4, cadre logique)	Relevé sur registre communautaire électronique + vérification par supervision ; consolidation annuelle	Semestrielle (Tech-4 : revues semestrielles, enquêtes de satisfaction semestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-02	Nombre / proportion de survivants de violences sexuelles ayant bénéficié d'une prise en charge holistique	DHIS2 ; rapports périodiques du projet et de la DPS ; rapports du sous-cluster VBG ; rapports d'enquêtes (Tech-4, cadre logique)	Extraction des registres VBG des FOSA appuyées + registre de référencement ; triangulation avec les rapports du sous-cluster	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-03	Proportion d'entités administratives décentralisées disposant d'une plate-forme multisectorielle de nutrition fonctionnelle	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles ; rapports périodiques de la DPS Kwilu (Tech-4, cadre logique)	Vérification documentaire (actes de mise en place, comptes rendus) + supervision conjointe DPS/consortium	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)

Code	Indicateur	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable de collecte	Responsable de validation
EFF-04	Proportion de FOSA disposant du paquet complet et ininterrompu des interventions de nutrition	DHIS2 ; rapports périodiques des ZS ; fiches de stock et bordereaux de livraison ; évaluations périodiques de la qualité (Tech-4, cadre logique)	Grille d'observation de la disponibilité du paquet (outil d'évaluation de la qualité développé avec le PRONANUT, Tech-4 §RI 1.3) + revue des fiches de stock	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-05	Taux d'initiation précoce de l'allaitement maternel	Enquête de base et enquête finale (SMART / CAP) ; DHIS2 ; fiches CPSr	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-23 mois ; données de routine des FOSA	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-06	Taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois	Enquête de base et enquête finale ; DHIS2 ; fiches CPSr et CPoN	Enquête auprès des mères d'enfants de 0-5 mois (rappel 24 h)	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-07	Pourcentage d'enfants de 6-23 mois bénéficiant d'une alimentation de complément adéquate (4 étoiles)	Enquête de base et enquête finale ; rapports d'activité des CAC ; fiches CPSr	Enquête auprès des mères/gardiens d'enfants de 6-23 mois ; observation des démonstrations culinaires	Début et fin de programme + rapports semestriels de suivi des indicateurs	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-08	Taux d'anémie des enfants de 6-23 mois à travers la supplémentation en multivitamines et minéraux	Enquête de base et enquête finale ; rapports de distribution des MNPs (Tech-4 : 600 000 boîtes de MNPs)	Mesure de l'hémoglobine lors des enquêtes ; rapprochement avec les registres de distribution	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-09	Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6-59 mois	Registres de VAD ; registres de distribution vitamine A ; DHIS2 ; enquêtes	Relevé des registres de distribution (FOSA et communautaire) et enquête auprès des ménages	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-10	Taux de déparasitage chez les enfants de 12-59 mois	Registres de déparasitage ; registres de VAD ; DHIS2	Relevé des registres de distribution et enquête auprès des ménages	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-11	Prévalence de l'insuffisance pondérale des enfants de 0-23 mois	Enquête de base et enquête finale (SMART) ; fiches CPSr	Mesure anthropométrique (poids et âge) lors des enquêtes	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-12	Pourcentage des ménages qui se lavent les mains aux moments critiques	Enquête CAP (connaissances, attitudes, pratiques) de l'évaluation de base et finale ; observations lors des VAD	Observation directe et entretien auprès des ménages (enquête CAP)	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-13	Pourcentage de ménages ciblés ayant adopté les 3 autres pratiques familiales essentielles relatives à la nutrition	Enquête CAP ; rapports d'activité des CAC ; fiches de suivi des VAD	Enquête CAP auprès des ménages ; observation lors des visites à domicile	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-14	Taux de femmes enceintes ayant fait 4 CPN ou plus	DHIS2 (registres CPN) ; fiches CPN ; enquête auprès des ménages	Extraction DHIS2 et rapprochement avec les registres de CPN des FOSA	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-15	Pourcentage d'écoles ayant un jardin potager	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; rapports de suivi des écoles appuyées	Visite de terrain et fiche de suivi des écoles	Annuelle — proposition à valider	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-16	Pourcentage des ménages ayant un score optimal de diversification alimentaire	Enquête CAP ; rapports d'enquêtes variées (cadre logique Tech-4)	Enquête auprès des ménages (rappel de consommation sur 24 h)	Début et fin de programme	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-17	Nombre de séances de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS organisées dans les 10 ZS	Rapports d'activité des campagnes de sensibilisation ; plan média ; rapports d'utilisation de la ligne verte	Décompte à partir des comptes rendus et listes de présence ; consolidation par le chargé S&E;/HMIS	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)

Code	Indicateur	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable de collecte	Responsable de validation
EFF-18	Proportion de zones de santé disposant d'un comité local de lutte contre les VBG fonctionnel	Rapport de mise en place des comités et PV ; comptes rendus des réunions ; rapports périodiques du projet (cadre logique Tech-4)	Vérification documentaire et supervision conjointe avec la DPS	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EFF-19	Taux de prise en charge des enfants de 6-59 mois référés dans les unités nutritionnelles pour malnutrition aiguë sévère	Registres UNTA/UNTI ; fiches de suivi individuel ; fiches de référence et contre-référence ; DHIS2	Rapprochement des fiches de référence et des registres d'admission des unités nutritionnelles	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-01	Nombre de CAC, CODESA et UCODESA mis en place ou redynamisés	Cartographie actualisée des CAC, CODESA et UCODESA ; PV de mise en place et d'investiture ; rapports périodiques des ZS	Recensement documenté par les animateurs communautaires des ZS ; consolidation par le consortium ; vérification par supervision	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-02	Pourcentage de CAC, CODESA et UCODESA fonctionnels	Rapports de réunions mensuelles ; plans d'action communautaires ; DHIS2 ; évaluation de la fonctionnalité (Tech-4 §RI 3.1)	Grille de fonctionnalité issue de l'évaluation de base ; vérification trimestrielle par supervision	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-03	Nombre de relais communautaires (RECO) formés	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation	Décompte à partir des listes de présence signées et des rapports de formation en cascade	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-04	Nombre de prestataires de FOSA formés sur le paquet nutritionnel	Rapport de formation ; listes de présence ; rapport de suivi post-formation	Décompte à partir des listes de présence ; vérification par les 5 cadres de la DPS lors du suivi post-formation	Ponctuelle — à l'issue de chaque session de formation	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-05	Nombre de membres des équipes-cadres des zones de santé (ECZS) formés	Rapport de formation ; listes de présence	Décompte à partir des listes de présence	Ponctuelle	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-06	Nombre de sites de soins communautaires (SSC) appuyés et dotés	Bons de livraison ; PV de réception ; rapports de dotation	Rapprochement des bordereaux de livraison et des PV de réception signés	Semestrielle (proposition à valider)	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-07	Nombre de FOSA approvisionnées en intrants nutritionnels et outils de gestion	Bons de réception ; fiches de stock ; rapports d'approvisionnement	Rapprochement des bons de réception et des fiches de stock ; contrôle par supervision	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-08	Nombre de FARN (Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle) fonctionnels	Rapports de fin de construction ; rapports d'activité des FARN ; fiches de pesée quotidienne	Visite de terrain et fiche de suivi FARN ; vérification des registres de pesée	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-09	Nombre d'unités nutritionnelles thérapeutiques réhabilitées et de dépôts aménagés	Rapports de fin de construction / réhabilitation ; PV de réception des travaux	Réception technique des travaux et visite de conformité	Ponctuelle — à la réception des travaux	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-10	Nombre de FOSA dotées en kits PEP et intrants spécifiques de prise en charge des SVS	Bons d'expédition ; PV de réception ; fiches de stock	Rapprochement des bons de livraison et des PV de réception	Semestrielle (proposition à valider)	Spécialiste des marchés publics et de la logistique	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-11	Nombre de personnes formées ou recyclées sur les VBG/EAS/HS	Rapports de formation ; listes de présence	Décompte à partir des listes de présence	Ponctuelle	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-12	Nombre d'émissions radio et de spots de sensibilisation diffusés	Rapports de monitorage de la diffusion ; contrats de diffusion	Décompte à partir des rapports de monitorage des radios partenaires	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)

Code	Indicateur	Source de vérification	Méthode de collecte	Fréquence	Responsable de collecte	Responsable de validation
EXT-13	Nombre de plans d'action communautaire (PAC) élaborés et mis en œuvre	Les plans d'action communautaires ; rapports d'activité ; preuves de paiement des micro-projets	Revue documentaire des PAC et vérification par supervision	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-14	Nombre de CAC équipées du registre électronique de suivi communautaire	Factures d'achat des smartphones ; rapports de formation ; bons de livraison ; preuves de paiement des forfaits internet	Inventaire des équipements déployés et suivi des connexions au serveur de données	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-15	Nombre de plates-formes multisectorielles de nutrition mises en place (provinciale et territoriales)	Rapports de mise en place des comités ; comptes rendus de réunions trimestrielles	Vérification documentaire et participation aux réunions	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
EXT-16	Nombre d'écoles appuyées disposant d'un jardin potager fonctionnel	Rapports de la conférence sur la nutrition et la production alimentaire ; fiches de suivi des écoles	Visite de terrain et fiche de suivi	Annuelle — proposition à valider	Spécialiste en Nutrition	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
REA-01	Taux de complétude des rapports d'activité mensuels transmis au BCZS et au consortium	Registre de réception des rapports ; DHIS2 ; rapports d'audit de qualité des données	Suivi du registre de réception et extraction des taux de complétude DHIS2	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
REA-02	Taux de promptitude de transmission des données au DHIS2	DHIS2 ; registre de réception ; rapports de MAA	Extraction des délais de saisie DHIS2 et rapprochement avec le calendrier normé	Mensuelle (Tech-4 : rapportage mensuel DHIS2 / réunions de monitorage mensuelles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
REA-03	Nombre de sessions de Monitorage amélioré pour l'action (MAA) réalisées	Rapports d'activité MAA ; comptes rendus de sessions	Décompte à partir des comptes rendus et des plans d'action corrective élaborés	Trimestrielle (Tech-4 : revues et supervisions trimestrielles)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)
REA-04	Nombre d'évaluations et d'études réalisées (base, mi-parcours, finale, recherche opérationnelle)	Rapports d'évaluation ; protocoles de recherche ; rapports d'enquête	Revue documentaire des rapports validés	Ponctuelle (Tech-4 : évaluations à trois périodes clés)	Responsable S&E;/HMIS du consortium	Directeur de projet (validation finale) ; DPS/PRONANUT (validation technique)

*Les responsabilités indiquées correspondent aux postes prévus par Tech-4 (section B.1 et tableau des personnels). La validation finale par le Directeur de projet et la validation technique par la DPS/PRONANUT sont une **recommandation** : Tech-4 ne formalise pas explicitement ce circuit de validation.*

5.2 Indicateurs par objectif et par niveau de résultat

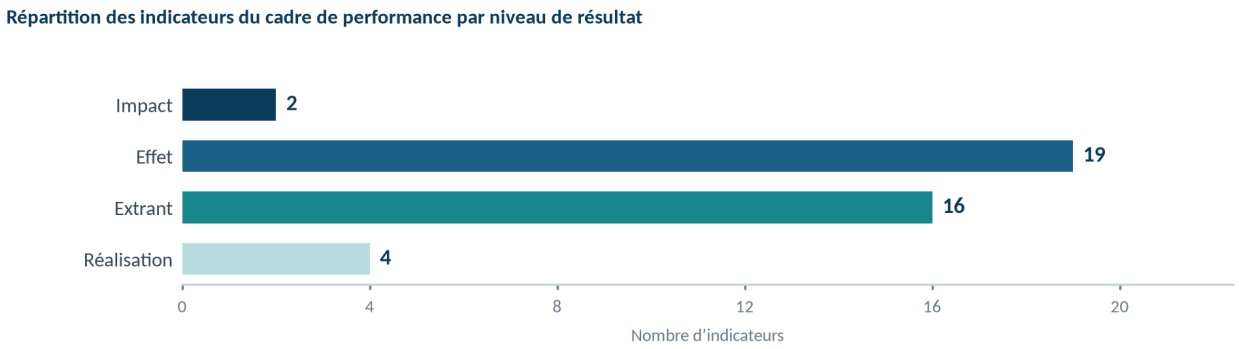


Figure 4 — Répartition des indicateurs par niveau de résultat

La prépondérance des indicateurs d'effets s'explique par la liste d'indicateurs que Tech-4 attache explicitement à l'objectif spécifique 1.

Tableau 13 — Couverture du cadre de performance par objectif

Objectif	Intitulé	Impact	Effet	Extrant	Réalisation	Total
OG	Objectif global	2	4	0	0	6
OS1	OS1 — Sites communautaires	0	12	6	0	18
OS2	OS2 — VBG	0	2	2	0	4
OS3	OS3 — Participation communautaire	0	0	4	0	4
OS4	OS4 — Système de santé	0	1	4	0	5
OS5	OS5 — Suivi-évaluation	0	0	0	4	4
Total		**2**	**19**	**16**	**4**	**41**

Chaque objectif de Tech-4 est couvert par au moins un indicateur d'effet ou d'extrant.

5.3 Procédure de fixation des valeurs de référence et des cibles

Tech-4 ne permet pas de renseigner les valeurs de référence ni les cibles annuelles. La procédure suivante est proposée pour combler cette lacune de manière traçable et concertée.

Tableau 14 — Procédure proposée de fixation des références et des cibles

Étape	Contenu	Responsable proposé	Échéance proposée
1	Établir les valeurs de référence de tous les indicateurs au moyen de l'évaluation de base (enquêtes SMART, CAP, état des lieux des FOSA, évaluation de la fonctionnalité des CAC)	Responsable S&E;/HMIS, avec la DPS/PRONANUT	T1 2027
2	Consolider les valeurs de référence dans une fiche de référence unique, validée par le Directeur de projet et endossée par la DPS	Responsable S&E;/HMIS	Fin T1 2027
3	Fixer les cibles 2027 et 2028 lors d'un atelier de validation réunissant le consortium, la DPS/PRONANUT, les ECZS et l'UG-PDSS	Directeur de projet	T1 2027
4	Reporter les cibles dans le cadre de performance (livrable 03) et les notifier officiellement	Responsable S&E;/HMIS	T2 2027
5	Réviser les cibles 2028 à l'issue de l'évaluation à mi-parcours, selon une procédure écrite de révision	Comité de pilotage	T4 2027

***Recommandation à valider** : cette procédure n'est pas décrite dans Tech-4. Elle respecte en revanche les principes du document source (recours à l'évaluation de base, validation par la DPS et le PRONANUT, revues semestrielles).*

5.4 Désagrégations retenues

Les désagrégations minimales proposées sont : le sexe, le groupe d'âge (0-23 mois, 24-59 mois, 5-17 ans, 18-59 ans, 60 ans et plus), la zone de santé, l'aire de santé, le milieu (urbain/rural), le type de formation sanitaire (CS/HGR) et, pour les indicateurs communautaires, le statut de la structure (CAC/CODESA/UCODESA). Tech-4 impose par ailleurs trois désagrégations explicites : la zone de santé, le sexe et l'âge pour les cas de VBG, et le statut UNTA/UNTI pour la prise en charge.

5.5 Indicateurs non retenus et justification

Certains indicateurs évoqués dans Tech-4 n'ont pas été retenus comme indicateurs de performance, faute de définition ou de possibilité de mesure dans le dispositif :

- **« % de CAC, CODESA et UCODESA dont les performances [...] atteignent 80 % »** (cadre logique) : la liste des performances contractuelles n'est pas fournie par Tech-4 ; l'indicateur EXT-02 mesure la fonctionnalité sans ce seuil, qui reste à définir.
- **Indicateurs du SNSAP** : Tech-4 prévoit le renforcement du système de surveillance nutritionnelle et de sécurité alimentaire dans les sites sentinelles, sans en définir les indicateurs.
- **Indicateurs de la recherche opérationnelle** : les questions de recherche ne sont pas encore sélectionnées ; elles feront l'objet d'un protocole distinct.

5.6 Cohérence entre les livrables

Le registre ci-dessus est la source unique du cadre de performance (livrable 03) et des fiches techniques du livrable 04. Toute modification d'un indicateur doit être répercutée dans les trois livrables ; la colonne « Code » sert de clé de correspondance et permet une vérification automatique de cohérence, réalisée lors du contrôle qualité (livrable 05).

SECTION 6

Organisation institutionnelle du suivi-évaluation

6.1 Acteurs et responsabilités documentés

Tech-4 décrit l'organisation du consortium et identifie les fonctions chargées du suivi-évaluation. Le tableau ci-après ne retient que les responsabilités explicitement rattachées à un poste ou à une institution dans le document source.

Tableau 15 — Acteurs et responsabilités documentés

Acteur	Rôle documenté dans Tech-4	Référence
Comité de pilotage du consortium (CPP)	« Se réunira de manière ordinaire sur base trimestriel[le] » ; cadre de concertation des membres du groupement sur les orientations stratégiques et les performances attendues	§B.2.1
Directeur de projet	Assure le leadership général du projet ; responsable de la validation et de la transmission des rapports	§B.2.1 ; §B.1
Responsable S&E; / HMIS (poste clé K3)	Pilotage du plan de suivi-évaluation, des revues internes, du feedback sur les rapports de terrain, des rapports d'avancement mensuels, trimestriels et annuels	§RI 4.5 ; §B.1
Spécialiste en Nutrition (poste clé K2)	Responsable de la majorité des activités de nutrition et de leur rapportage	§B.1
Spécialiste des marchés publics et de la logistique (K5)	Dotations, approvisionnements, bons de livraison et procès-verbaux de réception	§B.1 ; §RI 4.2
Gestionnaire financier (K4)	Preuves de paiement, rapports financiers, appuis financiers aux structures	§B.1 ; §RI 3.1
Spécialiste engagement communautaire et genre	Volet VBG, sensibilisation, comités locaux	§OS2 ; §B.2
Conseillers des ZS en NAC et en engagement communautaire (14 postes)	Accompagnement de proximité des ZS, des CAC et des RECO	§RI 4.4
DPS Kwilu / PRONANUT	Validation technique, développement des outils d'évaluation de la qualité, revues périodiques, bulletins trimestriels, audits de qualité des données	§RI 1.3 ; §RI 4.2 ; §RI 4.5
ECZS (équipes-cadres des zones de santé)	Supervision mensuelle, formation en cascade, validation des données de la ZS	§RI 4.2 ; §RI 4.5
UG-PDSS	Destinataire des rapports d'avancement mensuels, trimestriels et annuels ; évaluations mensuelles de vérification des performances	§RI 4.4 ; §RI 4.5
CAC, CODESA et UCODESA	Collecte communautaire, monitorage mensuel, bulletin de performance communautaire, contrôle communautaire et gestion des plaintes	§OS3 ; §RI 4.5

Les responsabilités de validation finale et de contrôle de second niveau ne sont pas formalisées dans Tech-4 au-delà de ce qui est indiqué ; elles font l'objet de la matrice RACI proposée en 7.2.

6.2 Matrice RACI proposée

> **Recommandation à valider**
>
> Tech-4 annonce une « matrice des responsabilités pour chaque objectif du projet » mais ne la reproduit pas dans le formulaire. La matrice ci-dessous est donc une **proposition** méthodologique, construite à partir des postes et des responsabilités effectivement décrits. Elle doit être validée en atelier avec la DPS/PRONANUT et l'UG-PDSS.

Tableau 16 — Matrice RACI proposée pour le suivi-évaluation

Activité de suivi-évaluation	Resp.	Approuve	Consulté	Informé
Élaboration et mise à jour du plan de S&E;	Resp. S&E;	Dir. projet	DPS, UG-PDSS	CPP
Évaluation de base et enquêtes	Resp. S&E;	Dir. projet	DPS/PRONANUT	UG-PDSS

Activité de suivi-évaluation	Resp.	Approuve	Consulté	Informé
Collecte de routine (FOSA et communauté)	Sp. Nutrition / Conseillers ZS	Resp. S&E;	ECZS	DPS
Consolidation des données communautaires	PrésiCAC / CODESA	ECZS	Resp. S&E;	CAC
Contrôle de la qualité des données (MAA, audits)	Resp. S&E;	DPS/PRONANUT	ECZS	CPP
Analyse et interprétation	Resp. S&E;	Dir. projet	Sp. Nutrition	CPP
Production des rapports périodiques	Resp. S&E;	Dir. projet	DPS	UG-PDSS
Revues semestrielles de la nutrition	DPS (présidence)	Gouverneur	Consortium, PTF	UG-PDSS
Évaluations à mi-parcours et finale	Resp. S&E;	Dir. projet	DPS, UG-PDSS	CPP
Capitalisation et recherche opérationnelle	Resp. S&E;	Dir. projet	ESP, DPS	PTF
Gestion des plaintes et redevabilité	Sp. engagement communautaire	Dir. projet	CAC, CODESA	Communautés

R = responsable de l'exécution ; A = approbateur ; C = consulté ; I = informé. ***Proposition à valider*** *— Tech-4 ne fournit pas cette matrice.*

6.3 Dispositif institutionnel

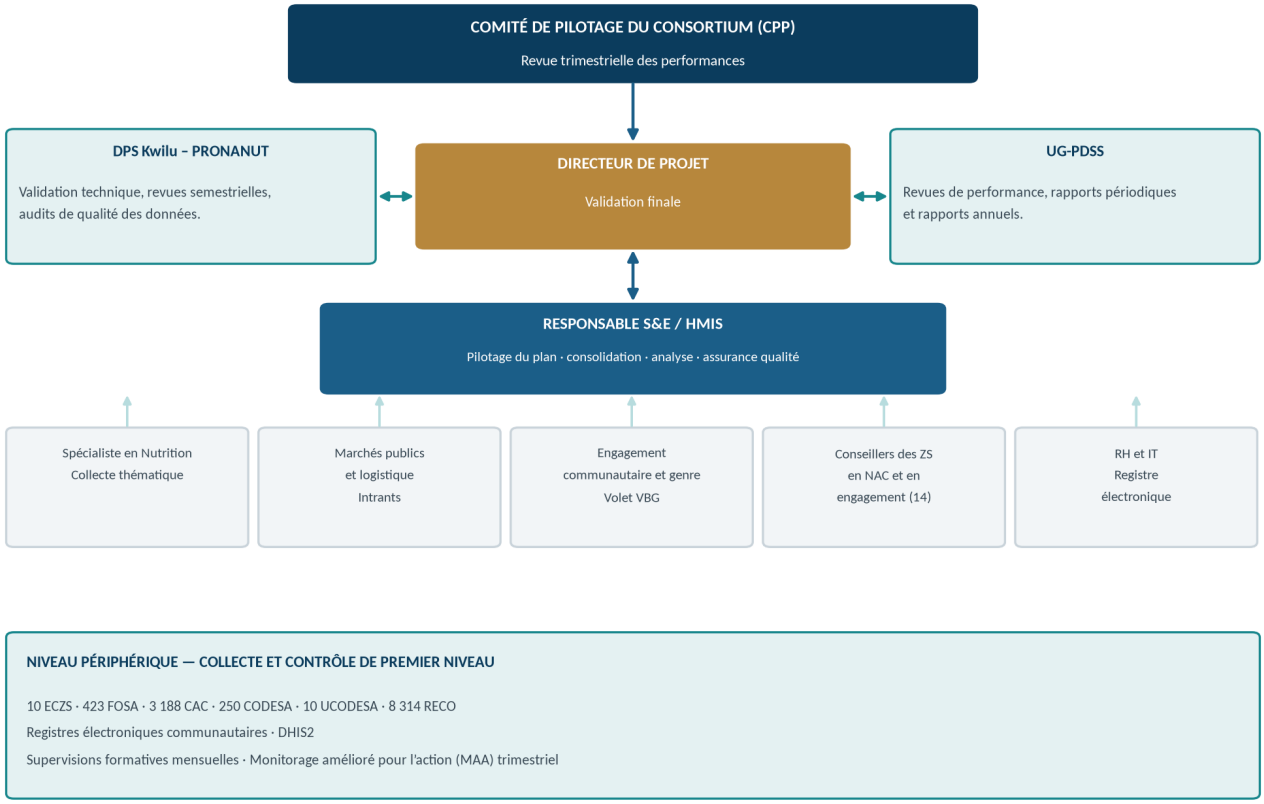


Figure 5 — Dispositif institutionnel du suivi-évaluation

Organigramme reconstitué à partir de la structure de mise en œuvre décrite dans Tech-4 (§B.2.1) et des fonctions de suivi-évaluation identifiées au §RI 4.5.

SECTION 7

Outils de collecte et de gestion des données

Tech-4 mentionne un ensemble d'outils dont une partie existe déjà dans le système de santé et une autre sera développée par le projet. Le tableau distingue explicitement ces deux situations : il ne prétend pas que les outils non mentionnés existent.

Tableau 17 — Outils de collecte et de gestion des données

Outil	Statut selon Tech-4	Usage dans le dispositif	Support
Registres de FOSA (registre curatif, registre UNTA/UNTI, fiches de suivi individuel, fiches CPS)	Existant — à approvisionner (826 exemplaires par registre pour les CS, 20 pour les HGR)	Collecte de routine des données cliniques et nutritionnelles	Papier, saisi dans DHIS2
Fiches de référence et contre-référence	Existant — 20 595 fiches prévues pour les CS	Traçabilité des orientations des cas MAS et des SVS	Papier
Registre communautaire électronique (RECO et PrésiCAC)	À mettre en place — innovation du projet ; 2 738 smartphones	Dénombrement, suivi individualisé des cibles, alertes nutritionnelles, synchronisation Bluetooth puis serveur	Application mobile + serveur
DHIS2 (SNIS)	Existant — plateforme nationale jusqu'au niveau de la zone de santé	Routine mensuelle, indicateurs de couverture, base des bulletins trimestriels	Plateforme web
Bulletin de performance communautaire (BCP)	Existant — à systématiser	Auto-évaluation communautaire, plan de redressement, redevabilité	Formulaire papier consolidé
Canevas et guides de supervision	À développer et valider par la DPS, les ECZS et le projet	Supervisions formatives mensuelles ; supervision des CAC	Papier / tablette
Formulaires de supervision des RECO (observation de VAD, évaluation de cas, spot check)	À développer (explicitement prévu)	Contrôle de la qualité des visites à domicile	Papier / tablette
Grille d'évaluation de la qualité des services de nutrition	À développer avec le PRONANUT, à partir des outils existants du Ministère	État des lieux, supervisions formatives, évaluations périodiques	Papier / tablette
Questionnaires d'enquête (SMART, CAP, satisfaction)	À développer pour l'évaluation de base ; enquêtes de satisfaction semestrielles prévues	Mesure des indicateurs de résultat et de perception	Tablette
Fiches de stock, bons de commande, de livraison, de réception et de sortie, RUMER, carnet d'ordonnances	Existant — à approvisionner (413 lots pour les CS, 10 pour les HGR)	Gestion et traçabilité des intrants nutritionnels	Papier
Registre des plaintes et ligne verte	À mettre en place (comités de gestion des plaintes dans chaque village)	Redevabilité, traitement des plaintes, protection	Papier + ligne téléphonique
Tableau de bord de projet	Non mentionné dans Tech-4 — **proposition**	Synthèse mensuelle des indicateurs pour l'UGP et le CPP	Tableur / outil de restitution

La colonne « Statut selon Tech-4 » distingue strictement ce qui existe, ce qui est à approvisionner et ce qui est à développer. Le tableau de bord de projet est explicitement identifié comme une proposition non prévue par le document source.

7.1 Architecture des données

Les données suivent trois circuits convergent vers le responsable S&E;/HMIS : un circuit clinique (FOSA → BCZS → DHIS2), un circuit communautaire (RECO → PrésiCAC → serveur du projet, avec consolidation par le CODESA et l'ECZS) et un circuit d'enquête (collecte sur tablette → contrôle qualité → base d'analyse). La convergence est assurée par un identifiant commun de zone de santé, d'aire de santé et de période.

7.2 Protection des données et éthique

Tech-4 prévoit la confidentialité dans le traitement des plaintes et la protection des survivants de violences sexuelles. Le dispositif de suivi-évaluation applique trois règles : agrégation des données VBG avant diffusion, anonymisation

des identifiants individuels dans les rapports, et approbation du protocole de recherche opérationnelle par le comité d'éthique de l'École de Santé Publique, comme le prévoit Tech-4.

7.3 Garanties de confidentialité et responsabilités associées

Tableau 17 bis — Garanties de confidentialité et responsabilités

Donnée sensible	Règle de traitement	Responsable	Fondement dans Tech-4
Cas de violences basées sur le genre	Agrégation avant tout rapport ; aucune donnée nominative dans les rapports périodiques ; diffusion limitée aux niveaux habilités	Spécialiste engagement communautaire	Tech-4 §OS2 : prise en charge confidentielle et protection des survivants
Plaintes et alertes communautaires	Traitement par le comité de gestion des plaintes ; registre tenu séparément ; ligne verte comme canal alternatif	Comité de gestion des plaintes	Tech-4 §OS3 : contrôle communautaire et gestion des plaintes
Données individuelles des bénéficiaires (registre électronique)	Identifiants pseudonymisés ; accès restreint ; conservation limitée à la durée du projet et à son évaluation	Responsable S&E; / HMIS	Tech-4 §RI 3.2 : registre électronique communautaire (innovation du projet)
Données relatives aux victimes de violences sexuelles	Aucune diffusion nominative ; analyse par zone de santé, sexe et âge uniquement	Responsable S&E; / HMIS avec la DPS	Tech-4 §OS2 : désagrégation exigée par zone de santé, sexe et âge
Recherche opérationnelle	Approbation préalable par le comité d'éthique de l'École de Santé Publique	Responsable S&E;	Tech-4 §RI 4.5 : protocoles soumis à l'approbation du comité d'éthique

*Les règles de traitement sont une **proposition** de mise en œuvre ; elles s'appuient sur les engagements de confidentialité et de protection que Tech-4 formule explicitement.*

SECTION 8

Assurance qualité des données

Tech-4 identifie explicitement trois dimensions — *« la complétude, la promptitude et la cohérence »* — et souligne que *« la qualité des données n'est pas optimale »* dans le système national. Le présent plan retient sept dimensions et associe à chacune un contrôle et un responsable.

Tableau 18 — Dimensions de la qualité des données et contrôles associés

Dimension	Définition appliquée	Contrôle mis en place	Responsable	Réf.
Validité	L'indicateur mesure bien ce qu'il prétend mesurer ; les définitions sont respectées	Revue annuelle des définitions ; comparaison des formules avec le registre ; validation par la DPS	Resp. S&E; + DPS	T4
Fiabilité	Les résultats sont stables dans le temps et entre collecteurs	Double saisie sur un échantillon ; comparaison entre registre papier et registre électronique	Resp. S&E;	T4
Précision	Les valeurs sont exactes et reproductibles	Vérification inopinée de cas ; recomptage lors des supervisions ; TPM ponctuel	ECZS + Resp. S&E;	T4
Exhaustivité	Toutes les structures et tous les cas attendus sont couverts	Suivi du taux de rapportage par FOSA et par CAC ; relance des structures silencieuses	ECZS + Resp. S&E;	T4
Cohérence	Les données sont concordantes entre sources et entre périodes	Réconciliation DHIS2 / registres communautaires ; analyse des écarts ; MAA trimestriel	Resp. S&E; + DPS	T4
Ponctualité	Les données sont disponibles dans les délais requis	Suivi de la promptitude mensuelle ; tableau de bord des retards	Resp. S&E;	T4
Traçabilité	Chaque valeur peut être rattachée à sa source primaire	Codification des rapports ; archivage des preuves ; registre de versions des indicateurs	Resp. S&E;	Proposition

Les quatre premières dimensions et les dispositifs de contrôle sont explicitement prévus par Tech-4 (MAA, audits, TPM, supervision formative). La dimension « traçabilité » est une proposition complémentaire.

8.1 Mécanismes de contrôle et de validation à trois niveaux

Tableau 19 — Contrôles de qualité à trois niveaux

Niveau	Mécanisme	Périodicité	Preuve
Premier niveau — structure	Vérification de la complétude et de la cohérence du registre avant transmission ; réunion mensuelle de monitorage de la CAC et du CODESA	Mensuelle	Registre signé, compte rendu de réunion
Deuxième niveau — zone de santé	Supervision formative mensuelle par l'ECZS ; contrôle de la qualité des données lors du MAA trimestriel ; audits de complétude, de promptitude et d'exactitude	Mensuelle et trimestrielle	Rapport de supervision, rapport de MAA
Troisième niveau — province	Revue semestrielle de la nutrition sous la direction du Gouverneur et du Ministre provincial ; audits de la qualité des données ; Third Party Monitoring ponctuel ; bulletins trimestriels	Semestrielle et ponctuelle	Rapport de revue, bulletin trimestriel, rapport TPM

Chaque mécanisme est explicitement cité par Tech-4 (§RI 4.5).

8.2 Plan d'audit de la qualité des données

- **Audit initial** (T1 2027) : établir la ligne de base de la complétude, de la promptitude et de l'exactitude dans les 10 ZS, préalable indispensable à toute fixation de cible.
- **Audits trimestriels** intégrés aux sessions de MAA, portant sur un échantillon de FOSA et de CAC par zone de santé.
- **Third Party Monitoring ponctuel**, conformément à la pratique que Tech-4 attribue au FDSS depuis 2018, pour confronter les données des RECO aux données d'enquêtes ad hoc.

- **Audit de clôture** (T4 2028), avant l'évaluation finale, pour garantir la fiabilité des données utilisées dans le rapport final.

> **Recommandation à valider**
>
> La programmation et les taux d'échantillonnage des audits ne figurent pas dans Tech-4. Le calendrier ci-dessus est une proposition cohérente avec les mécanismes prévus (MAA trimestriel, revues semestrielles, TPM), mais doit être validé et dimensionné.

SECTION 9

Plan de reporting

Tech-4 prévoit expressément le suivi des « *rapports d'avancement mensuels, trimestriels et annuels à soumettre à l'UG-PDSS* », la production de bulletins trimestriels de la DPS sur les données de nutrition, des revues semestrielles et des rapports d'évaluation. La matrice ci-dessous organise ces productions et distingue celles qui sont documentées de celles qui sont proposées.

Tableau 20 — Matrice des rapports

Rapport	Objet	Contenu	Période couverte	Fréquence	Destinataire	Producteur
Rapport d'activité mensuel	Suivi de l'exécution	Activités réalisées, volumes, difficultés, plan du mois suivant	Mois	Mensuelle **(T4)**	BCZS, ECZS, UGP	Spécialiste Nutrition / Conseillers ZS
Rapport de monitorage communautaire	Suivi communautaire	Cibles dénombrées et servies, écarts, plan de redressement	Mois	Mensuelle **(T4)**	CODESA, ECZS	CAC / CODESA
Rapport d'avancement trimestriel	Redevabilité	Indicateurs, analyse des écarts, risques, exécution budgétaire	Trimestre	Trimestrielle **(T4)**	UG-PDSS, CPP	Resp. S&E; / Dir. projet
Bulletin trimestriel des données de nutrition	Diffusion de l'information	Indicateurs clés, niveau de mise en œuvre des activités	Trimestre	Trimestrielle **(T4)**	DPS, ZS, PTF	DPS avec appui du consortium
Rapport de MAA	Analyse des goulots d'étranglement	Goulots identifiés, actions correctrices, responsables, échéances	Trimestre	Trimestrielle **(T4)**	ECZS, DPS, communautés	Resp. S&E;
Rapport de revue semestrielle	Réorientation programmatique	Progrès, goulots persistants, décisions, recommandations	Semestre	Semestrielle **(T4)**	Gouverneur, Ministre provincial, PTF	DPS
Rapport d'avancement annuel	Redevabilité annuelle	Bilan de l'année, atteinte des cibles, perspectives	Année	Annuelle **(T4)**	UG-PDSS	Dir. projet
Rapport d'évaluation de base	Référence	Valeurs de référence, état des lieux	Démarrage	Ponctuelle **(T4)**	UG-PDSS, DPS, CPP	Resp. S&E;
Rapport d'évaluation à mi-parcours	Ajustement	Processus, premiers effets, recommandations	18 premiers mois	Ponctuelle **(T4)**	UG-PDSS, DPS	Resp. S&E;
Rapport d'évaluation finale	Redevabilité finale	Atteinte des objectifs, pérennité, leçons	Durée totale	Ponctuelle **(T4)**	UG-PDSS, DPS, PTF	Resp. S&E; / Dir. projet
Rapport de recherche opérationnelle	Apprentissage	Protocole, résultats, publication	Variable	Ponctuelle **(T4)**	DPS, ESP, PTF	Resp. S&E;
Tableau de bord de projet	Pilotage interne	Indicateurs clés, alertes, avancement	Mois et trimestre	Mensuelle **(R)**	UGP, CPP	Resp. S&E;
Note de capitalisation	Capitalisation	Bonnes pratiques, innovations, leçons apprises	Semestre	Semestrielle **(R)**	DPS, PTF, public	Resp. S&E;

***(T4)** = rapport explicitement prévu par Tech-4 ; **(R)** = production proposée, à valider. Les destinataires sont ceux que Tech-4 nomme comme parties prenantes du dispositif.*

9.1 Normes de production des rapports

- **Structure normalisée** : rappel des objectifs, méthodologie, résultats par indicateur, analyse des écarts, risques, recommandations, annexes de preuves.
- **Traçabilité** : chaque donnée chiffrée est référencée à sa source et à sa période.
- **Comparabilité** : les tableaux reprennent systématiquement référence, cible, réalisation et écart.
- **Validation** : tout rapport est visé par le responsable S&E;/HMIS puis approuvé par le Directeur de projet ; les rapports destinés à la DPS sont endossés par celle-ci.
- **Diffusion** : dépôt dans un espace partagé unique, avec numérotation et archivage.

Ces normes sont une **recommandation** : Tech-4 prévoit la production des rapports mais n'en normalise pas la structure.

SECTION 10

Planification des activités de suivi-évaluation 2027–2028

La programmation ci-après distingue sept familles d'activités : collecte des données, contrôle qualité, analyse, production des rapports, revues de performance, évaluations, et capitalisation et apprentissage. Chaque ligne porte une marque de source : **T4** lorsque la périodicité ou l'activité est directement issue de Tech-4, **R** lorsqu'il s'agit d'une proposition méthodologique soumise à validation.

10.1 Exercice 2027

Calendrier opérationnel du suivi-évaluation — exercice 2027

ACTIVITÉS DE SUIVI-ÉVALUATION	SOURC.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Collecte mensuelle de routine (DHIS2, registres FOSA et CAC)	T4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dénombrement et suivi individualisé (registre électronique)	T4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Évaluation de base : SMART, CAP, état des lieux FOSA/CAC	T4	■	■	■	■								
Atelier de validation des références et des cibles 2027	R			■									
Audit initial de la qualité des données	R			■	■								
Supervisions formatives et contrôles de premier niveau	T4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monitorage amélioré pour l'action (MAA) et audits	T4			■			■			■			■
Third Party Monitoring ponctuel des données communautaires	R					■						■	
Analyse trimestrielle des données et des écarts	R			■			■			■			■
Rapports d'avancement trimestriels à l'UG-PDSS	T4			■			■			■			■
Bulletins trimestriels des données de nutrition (DPS)	T4			■			■			■			■
Rapport d'avancement annuel 2027	T4												■
Enquêtes semestrielles de satisfaction des clients	T4						■						■
Revues semestrielles de la nutrition (province)	T4						■						■
Comité de pilotage du consortium	T4			■			■			■			■
Évaluation à mi-parcours	T4										■	■	
Révision des cibles 2028	R												■
Recherche opérationnelle : protocole et collecte	T4				■	■	■	■	■	■	■	■	■
Documentation des bonnes pratiques et leçons apprises	T4			■			■			■			■

Collecte des données · Contrôle qualité · Analyse des données · Production des rapports · Revues de performance · Évaluations · Capitalisation et apprentissage

T4 = calendrier directement issu de Tech-4 · R = proposition méthodologique soumise à validation

Figure 6 — Calendrier opérationnel du suivi-évaluation, exercice 2027

L'année 2027 concentre la mise en place du dispositif : évaluation de base, fixation des valeurs de référence et des cibles, premier cycle complet de monitorage et évaluation à mi-parcours. La colonne « Sourc. » indique l'origine de chaque échéance.

10.2 Exercice 2028

Calendrier opérationnel du suivi-évaluation — exercice 2028

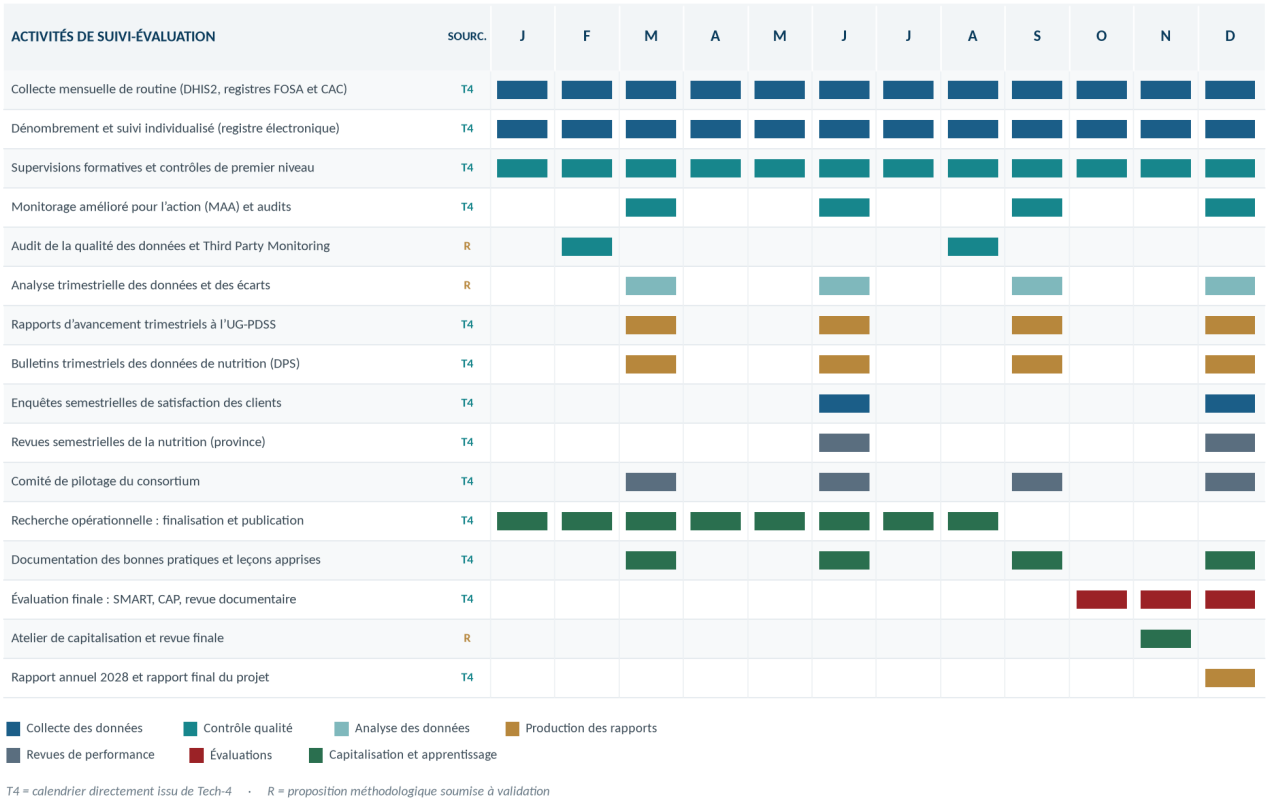


Figure 7 — Calendrier opérationnel du suivi-évaluation, exercice 2028

L'année 2028 consolide le dispositif, conduit l'évaluation finale et organise la capitalisation et la transmission des acquis.

10.3 Justification de la programmation

Tableau 21 — Traçabilité de la programmation

Activité programmée	Justification	Source
Évaluation de base au premier trimestre 2027	Tech-4 prévoit une évaluation de base « immédiatement au démarrage du projet » ; l'état des lieux précède l'évaluation de base dans le document source	Tech-4 §1.5 et §RI 4.5
Collecte mensuelle de routine	Tech-4 prévoit le rapportage mensuel des données au BCZS puis au DHIS2, et des réunions mensuelles de monitorage	Tech-4 §RI 4.5
MAA trimestriel	Tech-4 indique que « des sessions de MAA auront lieu chaque trimestre au niveau de la communauté, des centres de santé et des zones de santé »	Tech-4 §RI 4.5
Revues semestrielles	Tech-4 prévoit « une revue […] tous les 6 mois » sous la direction du Gouverneur	Tech-4 §RI 4.5
Enquêtes semestrielles de satisfaction	Tech-4 prévoit des « enquêtes semestrielles de satisfaction des clients »	Tech-4 §RI 1.3
Rapports trimestriels et annuels	Tech-4 prévoit la soumission de rapports d'avancement mensuels, trimestriels et annuels à l'UG-PDSS	Tech-4 §RI 4.5
Évaluations à mi-parcours et finale	Tech-4 prévoit trois temps d'évaluation (début, mi-parcours, fin) sans en fixer le calendrier	Tech-4 §RI 4.5
Audits de qualité des données et TPM	Tech-4 prévoit des audits lors des sessions de MAA et des TPM « de façon ponctuelle »	Tech-4 §RI 4.5
Recherche opérationnelle continue	Tech-4 prévoit de mener des recherches opérationnelles « tout au long du processus de mise en œuvre »	Tech-4 §RI 4.5

Activité programmée	Justification	Source
Positionnement mensuel précis des audits et des évaluations	Le mois exact n'est pas fixé par Tech-4 : la répartition proposée doit être validée	**Recommandation**

Cette matrice constitue la preuve de cohérence entre la programmation proposée et le document source : aucune échéance n'est présentée comme documentée lorsqu'elle ne l'est pas.

SECTION 11

Gestion des risques du dispositif de suivi-évaluation

Deux catégories de risques sont distinguées : les **risques documentés**, identifiés par Tech-4 lui-même (qualité des données, sous-déclaration des VBG, absence de dénominateurs fiables), et les **risques méthodologiques** propres à la conduite du dispositif de suivi-évaluation, proposés par le présent plan.

Tableau 22 — Registre des risques du dispositif de suivi-évaluation

N°	Risque	Nature	Conséquence sur le dispositif	Mesure d'atténuation proposée	Resp.
R1	Faible complétude et faible promptitude des données de routine	Documenté — Tech-4 §RI 4.5 et PNDS 2019-2022	Indicateurs non calculables ou calculés sur des données partielles	Suivi hebdomadaire des structures silencieuses ; relance par les ECZS ; tableau de bord des retards ; audits trimestriels	Resp. S&E;
R2	Non-fiabilité des dénominateurs de population cible	Documenté — Tech-4 §RI 4.5	Impossibilité de calculer des taux de couverture fiables	Actualisation mensuelle du dénombrement par les RECO ; validation par les ECZS ; recours aux données de dénombrement plutôt qu'aux projections	Resp. S&E; / ECZS
R3	Sous-déclaration des cas de VBG et incohérence entre sources	Documenté — Tech-4 §OS2	Sous-estimation systématique de la prise en charge	Triangulation DHIS2 / sous-cluster VBG / PNSR ; analyse des écarts explicitée dans les rapports ; ligne verte et notification communautaire	Sp. engagement communautaire
R4	Registres électroniques non opérationnels (réseau, équipement, appropriation)	Documenté — Tech-4 prévoit un déploiement pilote sur 2 ZS	Perte de la finesse du suivi individualisé	Maintien du registre papier en parallèle ; déploiement progressif ; maintenance et forfaits internet prévus	Resp. S&E; / IT
R5	Retard ou absence de l'évaluation de base	Méthodologique	Absence de valeurs de référence : le cadre de performance reste incomplet	Programmation dès janvier 2027 ; lancement en parallèle de l'état des lieux ; clause contractuelle de livraison	Dir. projet
R6	Cibles non arbitrées par les parties prenantes	Méthodologique	Absence de référence pour juger de l'atteinte des résultats	Atelier de validation au T1 2027 ; procédure écrite de révision ; traçabilité des décisions	Dir. projet
R7	Rotation du personnel formé et des points focaux	Documenté — Tech-4 prévoit un plaidoyer pour la stabilité des prestataires	Perte de compétences et rupture de la série de données	Plan de formation continue ; tutorat par les pairs ; clause de stabilité dans la convention avec la DPS	Sp. Nutrition
R8	Multiplicité des outils et des circuits de données	Méthodologique	Risque de double comptage et de divergence entre DHIS2 et registres du projet	Référentiel unique d'indicateurs ; règles de priorité entre sources ; réconciliation trimestrielle	Resp. S&E;
R9	Insécurité, intempéries et enclavement	Documenté — Tech-4 §Objectif 1 et §RI 4.4	Missions de supervision et collectes annulées ou retardées	Planification souple ; collecte décentralisée par les ECZS ; recours au téléphone et aux tablettes	Dir. projet
R10	Sur-sollicitation des acteurs de terrain (RECO, ECZS)	Méthodologique	Baisse de la qualité de la collecte et démobilisation	Regroupement des outils ; limitation du nombre d'indicateurs ; incitation basée sur la performance prévue	Sp. Nutrition
R11	Non-utilisation des données pour la décision	Méthodologique	Le dispositif produit des rapports sans effet sur la mise en œuvre	Ordre du jour décisionnel fixé pour chaque instance ; suivi des décisions ; revue de la mise en œuvre des recommandations	Dir. projet
R12	Décalage entre la durée prévue par Tech-4 (18 mois, échéance 2023) et la période 2027–2028	Méthodologique — lié au cadrage de la mission	Références et cibles historiques non transposables telles quelles	Actualisation de toutes les données de référence par l'évaluation de base 2027 ; révision explicite des échéances	Dir. projet / DPS

Les risques R1, R2, R3, R4, R7 et R9 sont explicitement documentés dans Tech-4 ; les autres sont des risques méthodologiques proposés par le présent plan.

11.1 Dispositif de suivi des risques

Le registre des risques est revu à chaque comité de pilotage trimestriel. Chaque risque fait l'objet d'un indicateur d'alerte, d'un responsable et d'une échéance de traitement. Tech-4 prévoit par ailleurs que le consortium « *identifiera, évaluera et documentera les risques* » au cours de l'évaluation de base et pendant la mise en œuvre, et qu'il mettra à jour ses plans de contingence.

11.2 Instances de revue des risques et calendrier de traitement

Tableau 22 bis — Instances de revue des risques

Instance	Objet de la revue des risques	Périodicité	Livrable de la revue
Réunion mensuelle de monitorage (CAC, CODESA)	Risques opérationnels locaux : structures silencieuses, ruptures d'intrants, absentéisme des prestataires	Mensuelle	Plan de redressement communautaire
Monitorage amélioré pour l'action (MAA)	Goulots d'étranglement identifiés par les données ; causes et mesures correctrices	Trimestrielle	Matrice des goulots et des actions
Comité de pilotage du consortium	Revue du registre complet ; risques R1 à R12 ; décisions d'atténuation et responsables	Trimestrielle	Compte rendu et registre actualisé
Revue semestrielle de la nutrition	Risques systémiques : qualité des données, disponibilité des intrants, couverture des zones	Semestrielle	Recommandations au Gouverneur et au Ministre provincial
Évaluation à mi-parcours et évaluation finale	Réévaluation des risques, de leur gravité et de l'efficacité des mesures prises	Ponctuelle	Rapport d'évaluation

*Les instances et leurs périodicités sont celles que Tech-4 prévoit ; le rattachement explicite du registre des risques à chacune d'elles est une **proposition** de mise en œuvre.*

11.3 Conséquences opérationnelles des risques majeurs

Trois risques conditionnent directement la fiabilité du cadre de performance et appellent une décision avant la première revue :

- **R2 — dénominateurs incertains.** Sans dénombrement validé, aucun taux de couverture ne peut être interprété. La décision attendue porte sur la méthode de dénombrement et sur la date de validation des chiffres par les ECZS.
- **R5 et R6 — absence de référence et de cibles.** Le cadre de performance reste inopérant tant que les valeurs de référence et les cibles ne sont pas arrêtées. La décision attendue porte sur la date de lancement de l'évaluation de base et sur la tenue de l'atelier de validation des cibles.
- **R12 — décalage temporel.** Les données de contexte de Tech-4 datent de 2017-2022 et l'échéance initiale était fixée à 2023. La décision attendue porte sur la confirmation écrite de la période contractuelle et sur l'actualisation de toutes les références.

Ces décisions sont inscrites à l'ordre du jour du premier comité de pilotage de 2027.

SECTION 12

Utilisation des résultats

Le dispositif n'a de valeur que par l'usage qui est fait des données. Tech-4 affirme la nécessité d'« *insister et introduire la culture de l'utilisation des données dans la gestion des programmes et la prise de décisions* ». Le tableau ci-après précise, pour chaque usage attendu, le mécanisme, l'instance et la périodicité.

Tableau 23 — Usages des résultats et instances de décision

Usage	Mécanisme	Instance	Périodicité
Suivre les progrès	Comparaison systématique référence / cible / réalisation dans les rapports périodiques et le tableau de bord	UGP, CPP	Mensuelle et trimestrielle
Identifier les écarts	Analyse des écarts par zone de santé, par aire de santé et par indicateur ; classement des structures selon la performance	ECZS, DPS	Trimestrielle
Améliorer les interventions	Plans de redressement issus du MAA et du BCP ; ajustement des stratégies de mise en œuvre	CAC, CODESA, ECZS	Trimestrielle
Orienter les décisions	Décisions consignées au compte rendu de chaque instance, avec responsable et échéance	CPP, DPS	Trimestrielle et semestrielle
Documenter les résultats	Rapports d'évaluation, notes de capitalisation, publications de la recherche opérationnelle	Consortium, DPS, ESP	Ponctuelle
Rendre compte aux parties prenantes	Rapports à l'UG-PDSS ; bulletins trimestriels de la DPS ; restitutions communautaires	UG-PDSS, communautés	Mensuelle à annuelle

Les instances et les périodicités reprennent celles que Tech-4 décrit ; le mécanisme « référence / cible / réalisation » et le suivi des décisions sont des propositions.

12.1 Boucle d'apprentissage

La boucle d'apprentissage s'organise en quatre temps : (i) la donnée est produite au niveau de la structure ; (ii) elle est analysée lors de la réunion de monitorage et du MAA ; (iii) elle est consolidée et confrontée aux autres sources lors de la revue semestrielle ; (iv) elle est transformée en décision au comité de pilotage, puis en ajustement du programme de travail. Chaque décision est tracée et son exécution est vérifiée à l'instance suivante.

12.2 Redevabilité envers les communautés

Tech-4 fait de la redevabilité un principe directeur : « *les prestataires des services devront ainsi être responsables envers les communautés qu'ils desservent* ». Le dispositif prévoit à cet effet trois instruments : le Bulletin de performance communautaire (BCP), le contrôle communautaire exercé par la CAC et le mécanisme de gestion des plaintes (registre de plaintes, ligne verte, comité villageois).

SECTION 13

Annexes

13.1 Annexe A — Référentiel des activités de suivi-évaluation issues de Tech-4

Le référentiel ci-dessous reprend les activités de suivi-évaluation que Tech-4 identifie dans son résultat intermédiaire 4.5 et dans son programme de travail (section B.1), avec le livrable et le responsable associés par le document source.

Tableau 24 — Annexe A : activités de suivi-évaluation identifiées par Tech-4

Code	Activité (Tech-4)	Livrable	Responsable (Tech-4)
5.1	Évaluation de base de la mise en œuvre du projet	Rapport de l'évaluation	Responsable S&E; / Directeur de projet
5.2	Monitorage amélioré pour action (MAA) avec des registres électroniques au niveau communautaire	Rapport d'activité	Responsable S&E;
5.3	Revues semestrielles de la nutrition	Rapport de revue	Responsable S&E;
5.4	Évaluations de la qualité de prise en charge de la malnutrition dans les établissements de santé	Rapport d'activité	Responsable S&E; / Spécialiste en Nutrition
5.5	Suivi des activités communautaires dans CAC, CODESA et UCODESA	Rapport d'activité	Responsable S&E; / Spécialiste en Nutrition
5.6	Contrôle communautaire	Rapport des plaintes et alertes communautaires sur le projet	Responsable S&E; / Spécialiste en Nutrition
5.7	Recherche opérationnelle	Protocole de recherche, rapport	Responsable S&E;
5.8	Documentation des bonnes pratiques, des innovations et des leçons apprises	Rapport de la mise en œuvre du projet	Responsable S&E;
5.9	Évaluation finale de la mise en œuvre du projet	Rapport de l'évaluation finale	Responsable S&E; / Directeur de projet
3.1.1	Évaluation de base de la mise en place et de la fonctionnalité des CAC et CODESA	Rapport de l'évaluation de base	Responsable S&E;/HMIS
4.4.1	État des lieux au niveau des aires de santé (FOSA, SSC, ressources humaines, équipements, intrants, infrastructures, indicateurs de base, analyse du genre)	Rapport des états des lieux	Spécialiste en Nutrition, Resp. S&E;/HMIS
4.2.9	Améliorer la qualité et l'utilisation des données nutritionnelles	Rapport d'activité	Spécialiste en Nutrition / Directeur
4.3.x	Appui aux réunions d'analyse des données (ECZS, COGE, CA, cluster, BCZS, PRONANUT, revues)	Compte rendu des réunions d'analyse	Responsable S&E;

Les libellés et les responsables sont ceux du document source. Le code « 4.3.x » regroupe les activités 4.3.1 à 4.3.6, dont le libellé est identique (« appui technique et financier aux réunions ») et dont seul l'objet diffère.

13.2 Annexe B — Modèle de fiche de suivi d'indicateur

Le modèle ci-dessous est à renseigner pour chaque indicateur et à archiver avec le registre. Il constitue la pièce justificative de la traçabilité.

Tableau 25 — Annexe B : structure normalisée d'une fiche de suivi d'indicateur

Rubrique	Contenu attendu
Code et intitulé	Identifiant unique repris du registre (section 5) et libellé complet
Objectif et résultat de rattachement	Objectif global, objectif spécifique et résultat intermédiaire de Tech-4
Définition et formule	Définition opérationnelle, numérateur, dénominateur, unité, règles d'arrondi
Niveau de résultat	Impact, effet, extrant ou réalisation

Rubrique	Contenu attendu
Valeur de référence	Valeur, date, source, méthode d'obtention, responsable de la validation
Cible 2027 / Cible 2028	Valeur, décision de fixation (référence de l'atelier), responsable
Source de vérification	Document ou base où la valeur est enregistrée, localisation
Méthode et fréquence de collecte	Instrument, échantillon, période de référence, périodicité
Responsables	Collecte, contrôle de premier niveau, validation, diffusion
Désagrégations	Sexe, âge, zone de santé, aire de santé, milieu, type de structure
Limites et biais connus	Sous-déclaration, dénominateur incertain, comparabilité dans le temps
Historique des modifications	Date, nature, justification, validation

13.3 Annexe C — Canevas du rapport d'avancement périodique

1. Page de garde et fiche d'identification (période, zones couvertes, version, validation).
2. Résumé d'une page : faits saillants, alertes, décisions demandées.
3. Rappel des objectifs et des résultats attendus concernés par la période.
4. Tableau de bord des indicateurs : référence, cible, réalisation, écart, commentaire.
5. Avancement du programme de travail : activités réalisées, livrables, taux d'exécution.
6. Analyse des goulots d'étranglement et des causes (cadre du MAA).
7. Qualité des données : complétude, promptitude, cohérence, mesures correctrices.
8. Risques et mesures d'atténuation (mise à jour du registre).
9. Décisions prises, responsables et échéances ; suivi des décisions antérieures.
10. Annexes : preuves documentaires, comptes rendus, listes de présence, photographies.

13.4 Annexe D — Matrice de traçabilité documentaire

La matrice ci-dessous relie chaque section du présent plan au passage correspondant de Tech-4, permettant une vérification indépendante de la fidélité au document source.

Tableau 26 — Annexe D : traçabilité entre le plan et le document source

Section du plan	Contenu	Source dans Tech-4
1. Présentation générale	Identification, contexte, objectifs, composantes, zones	Page de garde ; §1.1 à §1.3 ; §B.1 ; §RI 4.4 ; tableaux des ZS
2. Théorie du changement	Modèle EDO, chaîne des résultats	§1.5 (théorie du changement) ; cadre logique
3. Objectifs du dispositif	Objectifs, besoins d'information, utilisation	§RI 4.5 ; §RI 4.2
4. Approche méthodologique	Suivi, évaluations, triangulation, qualité	§RI 1.3 ; §RI 4.2 ; §RI 4.5
5. Registre des indicateurs	41 indicateurs, définitions, formules, cibles	Cadre logique ; §B.1 « Indicateurs » ; §RI 4.2 ; §OS2 ; §OS3
6. Organisation institutionnelle	Acteurs, RACI, dispositif	§B.2.1 (structure de mise en œuvre et personnels) ; §RI 4.5
7. Outils	Registres, DHIS2, BCP, questionnaires	§RI 4.2 ; §RI 4.5 ; tableaux de dotation
8. Assurance qualité	Dimensions, contrôles à trois niveaux	§RI 4.2 ; §RI 4.5
9. Reporting	Matrice des rapports	§RI 4.4 ; §RI 4.5
10. Planification	Calendriers 2027 et 2028	§RI 4.5 ; §B.1 (programme de travail)
11. Risques	Registre des risques	§1.4.7 ; §RI 4.5
12. Utilisation des résultats	Usages, boucle d'apprentissage, redevabilité	§1.4.6 ; §RI 4.5

13.5 Annexe E — Informations manquantes à obtenir

Tableau 27 — Annexe E : informations indispensables non disponibles dans Tech-4

Information manquante	Impact sur le suivi-évaluation	Modalité d'obtention proposée
Valeurs de référence de tous les indicateurs	Impossible de mesurer un progrès	Évaluation de base — T1 2027
Cibles annuelles 2027 et 2028	Impossible de juger de l'atteinte des résultats	Atelier de validation des cibles — T1 2027
Ventilation annuelle des volumes de livrables	Suivi d'exécution imprécis	Reprogrammation détaillée avec l'UG-PDSS
Budget du projet et clé de répartition des financements	Suivi financier non couvert par le présent plan	Documents budgétaires du consortium
Liste des indicateurs de performance conditionnant les primes communautaires	Financement basé sur la performance non mesurable	Cellule d'achat stratégique du consortium
Nombre exact de comités territoriaux multisectoriels à installer	Dénominateur de l'indicateur EFF-03	Arbitrage avec la DPS
Seuils de référence pour la qualité des services et la satisfaction	Comparabilité des enquêtes dans le temps	DPS/PRONANUT
Calendrier officiel des évaluations	Planification des ressources	UG-PDSS et consortium
Durée contractuelle effective du projet	Cadrage temporel des cibles	Convention de subvention

Aucune de ces informations n'a été inventée : elles sont signalées comme manquantes et leur modalité d'obtention est proposée.

13.6 Annexe F — Sigles et abréviations

Tableau 28 — Annexe F : sigles et abréviations

Sigle	Signification	Sigle	Signification
ANJE	Alimentation du nourrisson et du jeune enfant	MAA	Monitorage amélioré pour l'action
ATPE	Aliment thérapeutique prêt à l'emploi	MAM	Malnutrition aiguë modérée
BCP	Bulletin de performance communautaire	MAS	Malnutrition aiguë sévère
BCZS	Bureau central de la zone de santé	MILDA	Moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action
CAC	Cellule d'animation communautaire	MNPs	Micronutriments en poudre
CAP	Connaissances, attitudes et pratiques	NAC	Nutrition à assise communautaire
CODESA	Comité de développement sanitaire	ONG	Organisation non gouvernementale
CPN	Consultation prénatale	OS	Objectif spécifique
CPoN	Consultation postnatale	PEC	Prise en charge
CPSr	Consultation préscolaire redynamisée	PFE	Pratiques familiales essentielles
DHIS2	District Health Information Software 2	PMNS	Projet multisectoriel de nutrition et de santé
DPS	Division provinciale de la santé	PRONANUT	Programme national de nutrition
EAS/HS	Exploitation et abus sexuels / harcèlement sexuel	PTF	Partenaire technique et financier
ECZS	Équipe-cadre de la zone de santé	RECO	Relais communautaire
EHA	Eau, hygiène et assainissement	RI	Résultat intermédiaire
FARN	Foyer d'apprentissage et de réhabilitation nutritionnelle	S&E;	Suivi-évaluation
FEFA	Femme enceinte et femme allaitante	SGBV	Sexual and gender-based violence
FOSA	Formation sanitaire	SMART	Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions
HMIS	Health Management Information System	SNSAP	Système national de surveillance alimentaire et nutritionnelle
I.O.V.	Indicateur objectivement vérifiable	SNIS	Système national d'information sanitaire

Sigle	Signification	Sigle	Signification
IPC	Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire	SSC	Site de soins communautaires
K4 / K5	Poste clé n° 4 / n° 5 (gestionnaire financier / logistique)	TPM	Third Party Monitoring
UCODESA	Union des CODESA	UG-PDSS	Unité de gestion du Programme de développement du système de santé
UNTA / UNTI	Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire / intensive	VBG	Violences basées sur le genre
VAD	Visite à domicile	ZS	Zone de santé

13.7 Annexe G — Documents de référence

- Tech-4 — Description de l'approche, de la méthodologie et du programme de travail, Consortium SANRU-ICHESS-FONLIV-FDSS, DP N° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS (document source unique).
- Cadre de performance 2027–2028 (livrable 03) — version Excel et version PDF de consultation (livrable 04).
- Rapport de contrôle qualité (livrable 05) — traçabilité, informations manquantes, contrôles effectués.
- Références citées par Tech-4 et mobilisées dans le présent plan : MICS-Palu 2017-2018 ; MICS 6 (2018) ; IPC 2021-2022 ; DHIS2 2021 ; rapport annuel PRONANUT Kwilu 2020 ; DPS Kwilu 2021 ; Plan stratégique national de santé communautaire 2019-2022 ; PNDS recadré 2019-2022.